Министерство здравоохранения Республики Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра дерматовенерологии с курсом эндокринологии

Хворик Д.Ф.
Ковальчук Л.А.
Конкин Д.Е.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ: ТЕСТЫ

для студентов
лечебного и педиатрического факультетов

Гродно 2007

УДК 616.5+616.97](76.1)
ББК 55.8
Д36

Рекомендовано Центральным научно-методическим советом УО «ГрГМУ»
(протокол № от « 27 » февраля 2007г.)

Составители: зав. кафедрой, к.м.н. Д.Ф. Хворик
ассистент Л.А. Ковальчук
ассистент Д.Е. Конкин

Рецензент: зав. кафедрой инфекционных болезней с курсом детских инфекций, д.м.н., проф. В.М. Цыркунов

Д36 **Дерматовенерология:** тесты для студентов лечебного и педиатрического факультетов / Хворик Д.Ф., Ковальчук Л.А., Конкин Д.Е..- Гродно: ГрГМУ, 2007.- 85с.

Тесты по дерматовенерологии составлены согласно действующей учебной программы для студентов лечебного и педиатрического факультетов. В конце сборника представлены ответы к тестам. Тесты могут быть использованы для наработки навыков в клинической подготовке студентов во время практических занятий, а также в компьютерном варианте для тестирования знаний при проведении курсовых экзаменов.

Предназначено для студентов лечебного и педиатрического факультетов.

УДК 616.5+616.97](76.1)
ББК 55.8

© ГрГМУ, 2007

1. Кожа развивается из следующих зародышевых листков:
   1. экто- и мезодермы
   2. мезодермы
   3. энтеродермы
   4. эктодермы
2. Масса кожи без гиподермы составляет:
   1. 15% от веса тела
   2. 10% от веса тела
   3. 5% от веса тела
   4. 20% от веса тела
3. Площадь кожного покрова составляет:
   1. 1,5 – 2 кв. м
   2. 3,5 – 4 кв.м
   3. 4,5 – 5 кв.м
   4. 6 – 7,5 кв.м
4. За сутки с поверхности кожи испаряется:
   1. 600 – 800 мл водяных паров
   2. 50 – 100 мл водяных паров
   3. 200 – 300 мл водяных паров
   4. 1000 – 1500 мл водяных паров
5. Сальные железы выделяют за неделю:
   1. 100 – 200 гр. кожного сала
   2. 10 – 50 гр. кожного сала
   3. 300 – 400 гр. кожного сала
   4. 500 – 600 гр. кожного сала
6. В эпидермисе условно выделяют:
   1. 3 слоя
   2. 4 слоя
   3. 5 слоев
7. В эпидермисе различают слои, кроме:
   1. базального
   2. шиповатого
   3. зернистого
   4. блестящего
   5. рогового
   6. сетчатого
8. В эпидермисе располагаются:
   1. нервы
   2. сосуды
   3. эластические волокна
   4. аргирофильные волокна
9. Клетки эпидермиса:
   1. кератиноциты
   2. меланоциты
   3. тучные
   4. Лангерганса
10. Делящимися клетками эпидермиса являются:
    1. базальные
    2. лимфоциты
    3. макрофаги
    4. тучные
11. Что входит в мальпигиев слой эпидермиса:

1. базальный
2. роговой
3. шиповидный
4. блестящий

12. Для клеток базального слоя характерно:
1. пигментообразование
2. митозы
3. кератинообразование
4. секреция кожного сала

13. Роговой слой эпидермиса:
1. соприкасается с внешней средой
2. является верхним слоем эпидермиса
3. состоит из безъядерных ороговевших клеток
4. на различных участках кожного покрова разной толщины

14. В дерме различают следующие слои:
1. базальный
2. сосочковый
3. сетчатый
4. зернистый

15. Клетками собственно кожи являются:
1. фибробласты
2. Гринштейна
3. меланоциты
4. гистиоциты

16. Лимфатические сосуды расположены в:
1. базальном слое эпидермиса
2. сосочковом и сетчатом слоях дермы
3. подкожной жировой клетчатке
4. блестящем слое эпидермиса

17. Кровеносные сосуды расположены в:
1. в базальном слое эпидермиса
2. в дерме
3. в шиповатом слое эпидермиса
4. в гиподерме

18. Сосуды кожи иннервируются:
1. только симпатической нервной системой
2. только парасимпатической нервной системой
3. симпатической и парасимпатической нервной системой

19. Дермографизм это:
1. ответная реакция сосудов кожи на механическое раздражение
2. ответная реакция нервов кожи на механическое раздражение
3. ответная реакция мышц кожи на механическое раздражение

20. Дермографизм в норме:
1. белый
2. красный
3. смешанный
4. отсутствует

21. Что воспринимают тельца Фатера – Пачини и Гольджи – Маццони:
1. чувство глубокого давления
2. чувство тепла
3. чувство холода
4. боль

22. Что воспринимают тельца Мейснера:
    1. тактильную чувствительность
    2. чувство холода
    3. боль
    4. не участвуют в восприятии
23. Что воспринимают тельца Руффини:
    1. тепло
    2. боль
    3. чувство равновесия
    4. чувство холода
24. Что воспринимают клубочки Краузе:
    1. чувство холода
    2. боль
    3. чувство глубокого давления
    4. чувство тепла
25. Придатками кожи являются:
    1. волосы
    2. сальные железы
    3. потовые железы
    4. ногти
26. Волосы бывают:
    1. пушковые
    2. щетинистые
    3. длинные
    4. короткие
27. Волос состоит из:
    1. стержня
    2. корня
    3. мозгового слоя
    4. коркового слоя
28. Длинные волосы локализуются на:
    1. волосистой части головы
    2. бороде и усах
    3. надбровных дугах
    4. ушных раковинах
29. Щетинистые волосы локализуются везде, кроме:
    1. бороды и усов
    2. области надбровных дуг
    3. краев век
    4. преддверия носа
30. Различают следующие типы потовых желез:
    1. эккриновые
    2. апокриновые
    3. голокриновые
    4. нормокриновые
31. Укажите разновидности сальных желез:
    1. однодольчатые
    2. двухдольчатые
    3. пятидольчатые
32. Где локализуются сальные железы:
    1. на лице
    2. на волосистой части головы

3. на ладонях и подошвах

33. У кого апокриновые потовые железы не функционируют:
1. у мужчин
2. у женщин
3. у детей
4. у стариков

34. Основные функции кожи:
1. терморегулирующая
2. орган чувств
3. защитная
4. выделительная

35. Защитные свойства кожи от микроорганизмов осуществляются, благодаря:
1. потоотделению
2. слущиванию эпителия
3. кислой реакции
4. щелочной реакции

36. Первичными полостными элементами являются:
1. волдырь
2. пузырек
3. пустула
4. пузырь

37. Первичными бесполостными элементами являются:
1. папула
2. бугорок
3. волдырь
4. узел

38. К вторичным морфологическим элементам относятся:
1. чешуйки
2. рубец
3. узел
4. лихенизация

39. К вторичным морфологическим элементам не относятся:
1. пузырь
2. пустула
3. эрозия
4. вегетация

40. Какие первичные морфологические элементы исходят из эпидермиса:
1. эпидермальная папула
2. пузырек
3. пигментное пятно
4. пузырь

41. Какие первичные элементы заканчиваются язвами:
1. глубокая пустула
2. пузырек
3. узел
4. бугорок

42. Какие первичные элементы заканчиваются рубцами:
1. узел
2. пузырек
3. бугорок
4. глубокая пустула

43. Какие первичные элементы заканчиваются образованием корок:

1. пузырь
2. пятно
3. пустула
4. пузырек

44. Заболевания, которые проявляются мономорфными высыпаниями:
1. псориаз
2. экзема
3. пузырчатка
4. дерматит Дюринга

45. Заболевания, которые проявляются полиморфными высыпаниями:
1. болезнь Дюринга
2. вторичный сифилис
3. псориаз
4. экзема

46. Исход волдыря:
1. эрозия
2. язва
3. пятно
4. исчезает бесследно
5. корка

47. Язва представляет собой:
1. дефект кожи в пределах эпидермиса
2. глубокий дефект кожи
3. изменение цвета кожи
4. незначительное утолщение кожи

48. Везикула является первичным морфологическим элементом при:
1. крапивнице
2. экземе
3. опоясывающем лишае
4. нейродермите

49. Какие первичные морфологические элементы исходят из сосочкового слоя дермы:
1. волдырь
2. эпидермальная папула
3. пузырек
4. поверхностная пустула

50. Какие первичные морфологические элементы исходят из подкожной жировой клетчатки:
1. глубокие гнойнички
2. узлы
3. пузыри
4. бугорки

51. Полиморфные высыпания возникают при заболеваниях, кроме:
1. псориаза
2. красного плоского лишая
3. контагиозного моллюска
4. вторичного сифилиса

52. Воспалительные сосудистые пятна:
1. розеола
2. пурпура
3. телеангиэктазии

53. Невоспалительные сосудистые пятна:

1. розеолы
2. эритема
3. сосудистые невусы

54. По глубине залегания папулы бывают:
1. эпидермальные
2. эпидермо-дермальные
3. гиподермальные
4. дермальные

55. Фолликулярными пустулами являются ниже перечисленные, кроме:
1. остиофолликулита
2. фолликулита
3. фурункула
4. импетиго

56. После вскрытия пузырька образуется:
1. вегетация
2. язва
3. чешуйка
4. эрозия

57. Какие клинические проявления соответствуют картине истинного полиморфизма:
1. бугорок, язва, корка, рубец
2. пятно, папула, везикула
3. узел, язва, рубец
4. пятно, волдырь, пузырь
5. пузырек, эрозия, корка

58. Патогистологические изменения кожи связаны с:
1. нарушением процессов ороговения
2. воспалительными или экссудативными процессами
3. пролиферативными процессами

59. Гиперкератоз характерен для:
1. ихтиоза
2. рубромикоза
3. хронической красной волчанки
4. истинной экземы

60. Паракератоз характерен для:
1. псориаза
2. красного плоского лишая
3. простого пузырькового лишая
4. вторичного сифилиса

61. Акантолиз характерен для:
1. опоясывающего лишая
2. рубцующегося пемфигоида
3. дерматита Дюринга
4. акантолитической пузырчатки

62. Спонгиоз характерен для:
1. экземы
2. неаконтолитической пузырчатки
3. простого пузырькового лишая
4. туберкулеза кожи

63. Акантоз характерен для:
1. микробной экземы
2. псориаза

3. бородавчатого туберкулеза
4. себорейной пузырчатки

64. Гранулез характерен для:
1. псориаза
2. красного плоского лишая
3. истинной экземы
4. фурункулеза

65. Папилломатоз характерен для:
1. контагиозного моллюска
2. вульгарных бородавок
3. туберкулезной волчанки
4. зоонозной форма микроспории

66. Вакуольная дегенерация (внутриклеточный отек) характерна для:
1. псориаза волосистой части головы
2. экземы
3. аллергического дерматита
4. ихтиоза

67. Баллонирующая дегенерация характерна для:
1. простого герпеса
2. опоясывающего лишая
3. витилиго
4. онихомикоза

68. Примочки показаны при:
1. Гиперкератозе
2. остром воспалении с мокнутьем
3. шелушении
4. зуде

69. В состав взбалтываемых смесей могут входить:
1. окись цинка
2. глицерин
3. вазелин
4. спирт

70. В мазевую основу не входят:
1. вазелин
2. спирт
3. вода
4. глицерин

71. В мазевую основу могут входить:
1. вазелин
2. древесный уголь
3. свиное сало
4. ланолин

72. Верна ли пропись?: Rp.: Zinci oxydi 20,0 Talci 20,0 Glycerini 40,0 Vaselini 40,0 Aq. destillate ad 100,0 M.D.S. Взбалтываемая смесь
1. да
2. нет

73. Верна ли пропись?: Rp.: Zinci oxydi 20,0 Talci 20,0 Glycerini 40,0 Vaselini 40,0 Aq. destillate ad 100,0 M.D.S. Взбалтываемая смесь
1. да
2. нет

74. Верна ли пропись?: Rp.: Sol. Thyamini bromidi 20 - 1,0 in amp. D.t.d. № 20. S. Для инъекций.
   1. да
   2. нет
75. Назовите противозудные средства:
   1. окись цинка
   2. ментол
   3. анестезин
   4. анилиновые краски
76. Дезинфицирующими средствами являются:
   1. кортикостероиды
   2. борная кислота
   3. окись цинка
   4. ментол
77. Кератолитическими средствами являются:
   1. ихтиол
   2. резорцин
   3. тальк
   4. салициловая кислота
78. Примочки оказывают следующее действие:
   1. согревающее
   2. противовоспалительное
   3. дезинфицирующее
   4. кератолитическое
79. Болтушки оказывают следующее действие:
   1. подсушивающее
   2. противозудное
   3. противовоспалительное
   4. кератопластическое
80. Лаки оказывают следующее действие:
   1. кератолитческое
   2. отслаивающее
   3. противовоспалительное
   4. противозудное
81. У новорожденных бывает:
   1. везикулопустулез
   2. эпидемическая пузырчатка
   3. псевдофурункулез
82. Возбудитель эпидемической пузырчатки новорожденных:
   1. стафилококк
   2. стрептококк
83. Эпидемическую пузырчатку новорожденных дифференцируют с:
   1. врожденной пузырчаткой
   2. сифилитической пузырчаткой
84. При лечении эпидемической пузырчатки назначают:
   1. антибиотики
   2. мази с антибиотиками
   3. вводят карантин
85. Псевдофурункулез - это:
   1. воспаление сально - волосяных фолликулов
   2. воспаление эккринных потовых желез
   3. воспаление апокриновых желез

86. Псевдофурункулез дифференцирует с:
   1. фурункулом
   2. подкожным адипонекрозом
   3. фолликулитами
87. Развитию псевдофурункулеза способствует:
   1. повышенная потливость
   2. перегревание
   3. негигиеническое содержание ребенка
88. Омфалит это:
   1. воспаление сально-волосеных фолликулов
   2. воспаление пупочной ранки
   3. воспаление потовых желез
89. При эпидемической пузырчатке новорожденных:
   1. страдает общее состояние ребенка
   2. может быть сепсис
   3. ускорение СОЭ, повышенная температура
90. Подкожный адипонекроз развивается:
   1. на 1-2 недели жизни ребенка
   2. на 1-2 месяце жизни ребенка
   3. на втором году жизни
   4. после полового созревания
91. Подкожный адипонекроз дифференцируют с:
   1. фурункулом
   2. абсцессом
   3. врожденной пузырчаткой
92. Исход подкожного адипонекроза:
   1. рассасывается бесследно
   2. кальцификация
   3. нагноение
93. При склереме новорожденных поражаются:
   1. лицо
   2. бедра и ягодицы
   3. ладони и подошвы
94. В лечении склеремы новорожденных применяют:
   1. гемотрансфузии
   2. витамины
   3. глюкокартикоиды
95. Для склеродемы новорожденных характерно:
   1. уплотнение кожи
   2. отек кожи
   3. при надавливание остается ямка
96. При опрелости у новорожденных поражается:
   1. лицо
   2. волосистая часть головы
   3. ягодицы и бедра
97. В лечении опрелости III степени применяют:
   1. присыпки
   2. примочки
   3. гормональные мази
98. Себорейный дерматит у новорожденных развивается:
   1. к концу 1-го месяца жизни
   2. к концу 1-2 недели жизни

3. к концу 1-2 года жизни

99. Для себорейного дерматита новорожденных характерно:
1. гиперемия кожи
2. обильное шелушение
3. инфильтрация кожи
4. пузыри

100. Десквамативная эритродермия новорожденных вызывается:
1. вирусами
2. стрептококками
3. стафилококками

101. Эксфолиативный дерматит Риттера новорожденных вызывается:
1. стрептококками
2. вирусами
3. стафилокакками

102. При эксфолиативном дерматите новорожденных возникают:
1. пузыри
2. папулы
3. гиперемия

103. При эксфолиативном дерматите новорожденных:
1. симптом Никольского положителен
2. симптом Никольского отрицателен

104. Стафилококки вызывают сикоз вульгарный:
1. простой лишай
2. гидраденит
3. фурункул

105. Для болезней грудного возраста характерны:
1. гидраденит
2. псевдофурункулез
3. сикоз вульгарный
4. эксфолиативный дерматит Риттера

106. Стрептококками вызываются:
1. простой лишай
2. импетиго
3. фолликулит
4. пузырчатка новорожденных

107. Волосяные фолликулы поражаются при:
1. импетиго
2. сикозе
3. фурункуле
4. псевдофурункулезе

108. При стафилодермиях поражаются:
1. гладкая кожа
2. слизистые
3. устья волосяных фолликулов
4. углы рта

109. При стрептодермиях поражаются:
1. гладкая кожа
2. волосяные фолликулы
3. сальные железы
4. потовые железы

110. При стафилодермиях поражаются:
1. гладкая кожа

2. слизистые
3. устья волосяных фолликулов
4. углы рта

111. Для лечения пиодермий применяют:
1. антибиотики
2. глюкокортикоидные гормоны
3. сульфаниламиды
4. вакцины

112. Для профилактики пиодермитов применяют:
1. дезинфекцию микротравм
2. УФО
3. витамины
4. общие ванны

113. Для лечения стафилококкового сикоза применяют:
1. биостимуляторы
2. глюкокортикоидные гормоны
3. антибиотики
4. мужские половые гормоны

114. Гидраденит вызывают:
1. стафилококки
2. стрептококки
3. синегнойная палочка
4. смешанная инфекция

115. В профилактике пиодермитов на производстве играет роль:
1. производственно-технические мероприятия
2. санитарно-гигиенические условия
3. лечебно-профилактические меры
4. санитарное просвещение

116. Вульгарный сикоз вызывается:
1. стафилакокками
2. стрептококками
3. вирусами

117. Вульгарнный сикоз чаще бывает у:
1. женщин
2. мужчин
3. детей

118. Вульгарный сикоз дифференцируют с:
1. красной волчанкой
2. псориазом
3. паразитарным сикозом
4. экземой

119. В лечении вульгарного сикоза применяются:
1. антибиотики
2. стероидные гормоны
3. иммунотерапия
4. цитостатики

120. Гидраденит бывает в:
1. подмышечной области
2. наружном слуховом проходе
3. ано-генитальной области
4. туловище

121. Гидроденит - это воспаление:

1. апокринных желез
2. сально-волосинных фолликулов
3. эккринных желез
4. молочных желез

122. Поверхностные стафилодермии:
1. остиофолликулит
2. фолликулит
3. фурункул
4. гидраденит

123. При глубоком фолликулите поражается:
1. устье фолликула
2. часть фолликула
3. весь фолликул
4. подкожная жировая клетчатка

124. Локализация фурункулов:
1. лицо
2. туловище
3. подошвы
4. ладони

125. При хроническом фурункулезе необходимо исключить:
1. сахарный диабет
2. ВИЧ-инфекцию
3. заболевания крови
4. инфекции, передающиеся половым путем

126. При остиофолликулитах применяют:
1. антибиотики внутрь
2. мази с антибиотиками
3. анилиновые краски
4. антимикотики

127. Для лечения карбункула применяются:
1. антибиотики внутрь
2. салициловая мазь
3. ихтиоловая мазь
4. оперативное вмешательство

128. Первичным морфологическим элементом при стрептококковом импетиго является:
1. пустула
2. фликтена (вялый пузырь)
3. волдырь
4. узел

129. Разновидности стрептококкового импетиго:
1. простой лишай
2. заеда
3. турниоль (околоногтевой импетиго)

130. В лечении стрептококкового импетиго применяют:
1. антибиотики внутрь
2. мази с антибиотиками
3. анилиновые краски
4. гормональные мази

131. Вульгарное импетиго вызывают:
1. стрептококки
2. стафилококки

3. смешанная инфекция
4. вирусы

132. Стрептодермией болеют чаще:
1. мужчины
2. женщины
3. дети

133. Какие из пиодермий требуют назначения антибиотиков внутрь:
1. карбункул
2. сикоз
3. фурункулез
4. остиофолликулит

134. Глубокие формы пиодермитов:
1. фурункул
2. карбункул
3. эктима
4. вульгарное импетиго

135. Контагиозным является:
1. стрептококковое импетиго
2. фурункулез
3. вульгарный сикоз
4. вульгарное импетиго

136. Основными показаниями для назначения антибиотиков при пиодермиях являются:
1. длительное хроническое течение заболевания
2. локализация глубоких пиодермий на лице
3. наличие регионарного лимфаденита
4. развитие анафилактического шока

137. Неспецифическая иммунотерапия больных фурункулезом включает:
1. аутогемотерапию
2. пирогенал
3. продигиозан
4. метилуарцил

138. Вирусами вызываются заболевания:
1. бородавки
2. герпес
3. красный плоский лишай
4. контагиозный моллюск

139. Какие вирусные болезни передаются половым путем:
1. генитальный герпес
2. опоясывающий лишай
3. остроконечные кондиломы
4. контагиозный моллюск

140. Какие морфологические элементы характерны для простого герпеса:
1. пузырьки, эрозии, корки
2. узелки, чешуйки
3. узелки, волдыри
4. гнойнички, язвы

141. Клинические проявления опоясывающего лишая:
1. ассиметрия поражений
2. безболезненность
3. пузырьки на фоне воспаленной кожи
4. отсутствие высыпаний

142. Для типичной формы опоясывающего лишая характерны:
   1. эритема
   2. отек
   3. эрозии
   4. некроз
143. Для опоясывающего лишая характерно:
   1. сгруппированная сыпь
   2. боли по ходу нервных стволов
   3. общее недомогание
   4. диффузная сыпь
144. Клинические разновидности опоясывающего лишая:
   1. гангренозный
   2. абортивный
   3. генерализованный
   4. язвенно-некротический
145. Простой пузырьковый лишай необходимо дифференцировать от:
   1. афтозного стоматита
   2. красного плоского лишая
   3. опоясывающего лишая
   4. твердого шанкра
146. Обычные бородавки необходимо дифференцировать от:
   1. бородавчатого туберкулеза кожи
   2. мозолей
   3. бородавчатого акрокератоза Гопфа
   4. себорейных бородавок
147. Остроконечные кондиломы небходимо дифференцировать от:
   1. широких кондилом
   2. вегетирующей пузырчатки
   3. вегетирующей пиодермии
   4. эпителиомы
148. При заразительном моллюске первичным элементом является:
   1. папула
   2. бугорок
   3. пузырек
   4. волдырь
149. Пути заражения остроконечными кондиломами:
   1. половой
   2. трансфузионный
   3. тесный бытовой контакт
   4. воздушно-капельный
150. Противовирусным эффектом обладают мази:
   1. серная
   2. оксолиновая
   3. завиракс
   4. декаминовая
151. Для лечения бородавок используют:
   1. кератолитические препараты
   2. противовирусные средства
   3. хирургические методы
   4. ПУВА-терапию
152. При контагиозном моллюске у ребенка следует провести следующие мероприятия:

1. изоляция от здоровых детей
2. гормональная терапия
3. УЗИ внутренних органов
4. антибиотиотерапия

153. Возбудитель чесотки:
1. вирус
2. простейшие
3. паразиты
4. бактерии

154. В каком слое кожи самка клеща прокладывает чесоточный ход:
1. в блестящем
2. в зернистом
3. в роговом
4. в шиповатом

155. Наиболее частая длительность инкубационного периода при чесотке:
1. 5-12 дней
2. 21 день
3. 6 недель
4. 4 мес

156. Пути заражения чесоткой:
1. половой
2. воздушно-капельный
3. через общую постель
4. при поцелуе

157. Основными симптомами чесотки являются:
1. парные папуло-везикулярные элементы
2. интенсивный зуд в вечернее и ночное время суток
3. наличие чесоточных ходов
4. характерная локализация высыпаний

158. При чесотке чаще поражаются:
1. межпальцевые промежутки
2. живот
3. лицо
4. половые органы

159. Для клиники чесотки характерны следующие морфологические элементы:
1. лентикулярные папулы
2. бугорки
3. парные зудящие узелки и пузырьки
4. узлы

160. Симптомы Горчакова-Арди, Михаэлиса, Сезари выявляются при:
1. чесотке
2. педикулезе
3. лейшманиозе
4. вульгарных угрях

161. Симптом Горчакова-Арди – это:
1. гнойные и кровянистые корочки в области локтевых суставов
2. кровянистые корочки в межягодичной складке
3. зуд, усиливающийся в вечернее время суток
4. экскориации вследствие расчесов

162. Клинические разновидности чесотки:
1. типичная
2. детская

3. чесотка без ходов
4. норвежская
5. «чистоплотных» или «инкогнито»
6. осложненная
7. скабиозная лимфоплазия кожи
8. псевдочесотка или псевдосаркоптоз

163. Укажите наиболее частые осложнения чесотки:
1. сепсис
2. вторичная пиодермия
3. экзема
4. дерматит

164. Диагностика чесотки должна основывается на:
1. жалобах пациента
2. эпиданамнезе
3. клинической картине
4. лабораторной диагностике

165. На основании какого метода лабораторной диагностики устанавливается окончательный диагноз «чесотка»:
1. посев на питательную среду
2. РИФ
3. ПЦР
4. микроскопия

166. Для постановки окончательного диагноза чесотки главным критерием является:
1. зуд
2. наличие расчесов
3. обнаружение чесоточного клеща
4. наличие пузырьков

167. Для лечения чесотки применяют:
1. спрегаль
2. бензил-бензоат
3. перметрин
4. любую гормональную мазь

168. Противоэпидемиологические мероприятия при чесотке:
1. душ до и после лечения
2. дезинфекция белья
3. вакцинация
4. профлечение контактных лиц

169. Назовите основные разновидности вшей, поражающих человека:
1. половные
2. платяные
3. бытовые
4. половые

170. Какие лекарственные средства используются для лечения педикулеза:
1. флуцинар
2. нео-пенотран
3. ниттифор
4. аугментин

171. Осложнения головного педикулеза:
1. пиодермия
2. алопеция
3. аллергические реакции
4. повышение температуры

172. Лобковым педикулезом можно заразиться:
   1. в бане
   2. при половых сношениях
   3. при посещении бассейна
   4. на пляже

173. Классификация дерматомикозов по МКБ – 10:
   1. микоз волосистой части головы
   2. микоз гладкой кожи
   3. микоз крупных складок
   4. микоз кистей и стоп
   5. микоз ногтей (онихомикоз)

174. Заболевания, относящиеся к трихомикозам:
   1. трихофития
   2. руброфития
   3. микроспория
   4. эпидермофития
   5. фавус

175. Виды микроспории:
   1. антропофильная (антропонозная)
   2. зоофильная (зоонозная)
   3. геофильная

176. Клинические формы зоонозной микроспории:
   1. волосистой части головы
   2. гладкой кожи

177. Источник заражения зоонозной микроспорией:
   1. грызуны
   2. кошки, собаки
   3. коровы, лошади
   4. птицы

178. Источник заражения хронической трихофитией:
   1. кошки
   2. люди
   3. птицы
   4. телята

179. Поверхностной трихофитией болеют:
   1. доярки
   2. дети
   3. взрослые мужчины
   4. работники ферм

180. Возбудителем рубромикоза является:
   1. Trichophyton rubrum
   2. Epidermophyton floccosum
   3. Corynebacteria minutissima
   4. Pityrosporum orbiculare

181. Возбудителем антропонозной микроспории является:
   1. Microsporum ferrugineum
   2. Microsporum lanosum
   3. Trichophyton schonleinii
   4. Trichophyton violaceum

182. Возбудителем антропофильной трихофитии является:
   1. Trichophyton violaceum
   2. Trichophyton rubrum

3. Pitysporum orbiculare
4. Trichophyton verrucosum
5. Microsporum ferrugenii

183. Возбудителем паразитарного сикоза является:
1. Trichophyton rubrum
2. Trichophyton Schoenleini
3. Trichophyton gypseum
4. Trichophyton violaceum

184. Люминесцентное свечение при обследовании с помощью лампы Вуда обнаруживается у больных с:
1. зоонозной микроспорией
2. поверхностной трихофитией
3. фавусом
4. инфильтративно-нагноительной трихофитией

185. Диагноз зоонозной микроспории волосистой части головы можно подтвердить с помощью:
1. микроскопии
2. пробы Бальцера
3. люминесцентного свечения
4. культуральной диагностики

186. На высоте 5- 8 мм над уровнем кожи волосы обламываются при:
1. трихофитии
2. микроспории
3. фавусе
4. гнездной алопеции

187. Для микроспории гладкой кожи не характерно:
1. наличие эритемато-сквамозных очагов
2. нечеткие границы и быстрое саморазрешение
3. шелушение
4. пузырьки по краю очага

188. Для диагностики грибковых заболеваний применяют следующие исследования:
1. серологические
2. микроскопические
3. иммунологические
4. бактериологические

189. Дифференциальная диагностика микроспории проводится с:
1. трихофитией
2. фавусом
3. себорейной экземой
4. розовым лишаем
5. рубромикозом

190. Для хронической трихофитии характерно:
1. обламыванием волос на уровне кожи — симптом "черных точек"
2. кораллово-красное свечение при обследовании с помощью лампы Вуда
3. на гладкой коже очаги не имеют резких границ, застойно-синюшного цвета
4. споры гриба внутри волос расположены по типу эндотрикс

191. При фавусе поражаются:
1. волосистая часть головы
2. ногти
3. гладкая кожа
4. внутренние органы

192. Для фавуса нехарактерно:
   1. наличие корок
   2. ломкость волос и образование папул
   3. рубцы
   4. атрофия волос
193. Клиника фавуса проявляется:
   1. обламыванием волос
   2. облысением
   3. атрофией
194. Для скутулярной формы фавуса характерно:
   1. атрофичность и безжизненность волос
   2. мышиный запах
   3. зуд
   4. рубцовая атрофия
195. Клинические формы эпидермофитии стоп:
   1. сквамозная
   2. дисгидротическая
   3. отрубевидная
   4. ногтей
196. Для паховой эпидермофитии не характерны:
   1. инфильтрация
   2. кирпично–красная окраска
   3. корралово-красное свечение при люменисценции
   4. папулезные высыпания
197. Клиника паховой эпидермофитии:
   1. Отечно-гиперемированное пятно
   2. Поражение ногтевых пластинок
   3. Воспалительный венчик по периферии очагов
   4. Зуд
198. Для глубокой трихофитии характерно:
   1. общее недомогание с повышением температуры тела
   2. наличие островоспалительного инфильтрата
   3. самопроизвольное разрешение
   4. симптом « медовых сот»
199. Для рубромикоза характерен:
   1. акантоз
   2. гиперкератоз
   3. спонгиоз
   4. паракератоз
200. Для лечения рубромикоза применяются:
   1. местные и системные антимикотики
   2. витамины
   3. цитостатики
   4. глюкокортикоиды
201. При рубромикозе поражаются:
   1. ногтевые пластинки
   2. пушковые волосы
   3. ладони и подошвы
   4. гладкая кожа
202. Ногтевые пластинки поражаются при:
   1. псориазе
   2. кандидозе

3. красном плоском лишае
4. рубромикозе

203. Для онихомикоза характерно:
1. деформация и утолщение ногтей
2. напертсковидная дистрофия
3. крошащийся и изъеденный со свободного края ноготь
4. тусклая, желтовато – серая окраска ногтей

204. Комплексное лечения микроспории включает:
1. гризеофульвин
2. наружные средства
3. витамины
4. антигистаминные препараты

205. Для общего лечения трихомикозов применяют:
1. нистатин
2. орунгал
3. ламизил
4. леворин

206. Для наружного лечения эпидермофитии применяют:
1. примочки в случае мокнутия
2. гормональные мази
3. противогрибковые мази
4. мази с нафталаном

207. Для наружного лечения микозов не применяются:
1. микосептин
2. ламизил
3. клотримазол
4. преднизолон

208. К псевдомикозам относятся:
1. трихофития
2. эритразма
3. актиномикоз
4. кандидоз

209. Эритразма локализуется в:
1. паховой области
2. подмышечных впадинах
3. стопах
4. ягодицах

210. Лечение эритразмы проводится:
1. эритромициновой мазью
2. оксолиновой мазью
3. анатоксином
4. оксикортом

211. Проба Бальцера положительная при:
1. кандидозе
2. эпидермофитии стоп
3. разноцветном лишае
4. рубромикозе

212. Кандидоз кожи и слизистых вызывает:
1. Trichophyton rubrum
2. Candida albicans
3. Epidermophyton floccosum
4. Corynebacteria minutissima

5. Pityrosporum orbiculare

213. Кандидоз кожи проявляется:
1. эрозиями
2. белым налетом
3. выраженным шелушением
4. мокнутием

214. При кандидозе поражаются:
1. волосистая часть головы
2. гладкая кожа
3. слизистые
4. ногтевые пластинки

215. Возбудителем отрубевидного лишая является:
1. Pityrosporum orbiculare
2. Corynebacterium minutissimum
3. Epidermophyton floccosum
4. Trichophyton mentagraphytes var interdigitale

216. Лечение отрубевидного лишая:
1. аэрозоль «Ламизил»
2. гидрокортизон
3. салициловый спирт
4. общее УФО

217. Основной тип аллергических реакций при васкулитах кожи:
1. анафилактоидные
2. цитотоксические
3. иммунокомплексные
4. анафилактоидные и цитотоксические

218. Васкулиты делятся:
1. на поверхностные и глубокие
2. на инфекционные и неинфекционные
3. на инфекционные и лекарственные
4. вроженные и приобретенные

219. При геморрагическом васкулите кроме кожи, поражаются:
1. нервная система
2. сосуды внутренних органов
3. суставные хрящи
4. эндокринная система

220. В патогенезе васкулитов играет роль:
1. наследственность
2. фокальная инфекция
3. пищевые аллергены
4. аутоиммунные процессы

221. Для аллергических васкулитов характерны:
1. острое начало
2. наличие геморрагического компонента в высыпаниях
3. полиморфизм высыпаний
4. кашель

222. Узловатая эритема проявляется:
1. узлами на коже туловища
2. узлами на коже голеней, бедер
3. повышением температуры
4. сезонностью

223. Для лечения васкулитов применяются:

1. антибиотики
2. гипосенсибилизирующие, антигистаминные средства
3. кортикостероиды
4. иммуномодуляторы

224. Профилактика аллергических васкулитов:
1. лечение фокальной инфекции
2. исключение переохлаждения
3. рациональное питание
4. лечение ревматизма

225. К зудящим дерматозам (нейродерматозам) относят:
1. атопический дерматит
2. ограниченный нейродермит
3. крапивницу
4. почесуху взрослых

226. К зудящим дерматозам не относят:
1. крапивницу
2. нейродермит
3. почесуху Гебры
4. розовый лишай Жибера

227. В какие времена года обычно наблюдаются рецидивы нейродермита:
1. весна
2. осень
3. зима
4. лето

228. В этиопатогенезе нейродермита играют роль:
1. функциональные нарушения нервной системы
2. наследственность
3. эндокринные расстройства
4. желудочно-кишечные интоксикации

229. При ограниченном нейродермите выделяют следующие зоны:
1. зону лихенификации
2. зону блестящих папул
3. зону гиперпигментации, переходящую в здоровую кожу
4. зону бугорков

230. Основные места локализации ограниченного нейродермита:
1. задне-боковая поверхность шеи
2. перианальная область
3. гениталии
4. сгибательная поверхность крупных суставов

231. Диффузный нейродермит следует дифференцировать с:
1. лимфомой кожи
2. генерализованным кожным зудом
3. почесухой
4. крапивницей

232. Для атопического дерматита характерно:
1. зуд
2. атопия в анамнезе
3. начало в детском возрасте
4. быстрая дессиминация процесса

233. Для атопического дерматита характерно:
1. не сезонный характер заболевания
2. локализация высыпаний на сгибательной поверхности конечностей

3. отмечается положительный симптом Никольского
4. белый дермографизм

234. Локализация высыпаний у больных с атопическим дерматитом:
1. лучезапястные суставы
2. лицо
3. шея
4. локтевые сгибы

235. Морфологический элемент характерный для детской почесухи:
1. волдырь
2. узел
3. микровезикула
4. серопапула

236. Выделяют следующие формы почесухи:
1. детская
2. взрослых
3. гайды
4. узловатая почесуха Гебры

237. Для почесухи характерны:
1. сильный зуд
2. красный дермографизм
3. эозинофилия
4. локализация на разгибателях конечностей

238. Какими высыпаниями проявляется крапивница:
1. папулами
2. волдырями
3. пузырьками
4. пузырями

239. Локализация первичного морфологического элемента при крапивнице:
1. в сосочковом слое дермы
2. в роговом слое эпидермиса
3. в зернистом слое эпидермиса
4. в гиподерме

240. Назовите разновидности крапивницы:
1. острая
2. хроническая
3. холодовая
4. солнечная

241. Какой дермографизм у больных крапивницей:
1. красный
2. белый
3. смешанный
4. дермогрфизм отсутствует

242. Основные клинические проявления острой крапивницы:
1. зуд
2. волдыри
3. экскориации
4. неприятный запах

243. Причиной хронической крапивницы могут быть:
1. тепло
2. холод
3. интоксикации
4. фокальная инфекция

244. По классификации кожный зуд делится на:
1. локализованный и генерализованный
2. острый и хронический
3. первичный и вторичный
4. постоянный и временный

245. К локализованному кожному зуду относятся:
1. зуд волосистой части головы
2. зуд ладоней
3. зуд перианальной области
4. зуд гениталий

246. При кожном зуде не характерно наличие:
1. волдырей
2. мокнутия
3. экскориаций
4. лихенизации

247. При жалобах на кожный зуд и отсутствии кожных высыпаний пациенту назначают:
1. общий анализ крови и мочи, биохимическое исследование крови
2. исследование уровня сахара крови
3. исследование кала на яйца гельминтов
4. электоэнцефалограмму головного мозга

248. Для уменьшения сосудистой проницаемости назначаются:
1. никотиновая кислота
2. глюконат кальция
3. аскорбиновая кислота
4. витамин В1

249. Для общего лечения нейродермита могут применяются:
1. антигистаминные средства
2. десенсебилирующие средсва
3. антиноксидантный комлекс
4. ламизил

250. К пузырным дерматозам не относится:
1. вульгарная пузырчатка
2. буллезный пемфигоид
3. герпетиформный дерматоз
4. пузырчатка новорожденных

251. Пузырный дерматоз, при котором пузыри обычно начинаются со слизистой полости рта:
1. вульгарная пузырчатка
2. семейная пузырчатка
3. сифилитическая пузырчатка
4. болезнь Дюринга-Брока

252. Разновидностями истинной пузырчатки являются:
1. вегетирующая
2. буллезный пемфигоид
3. листовидная
4. себорейная

253. В группу акантолитической пузырчатки не входит:
1. вульгарная
2. себорейная
3. вегетирующая
4. семейная

254. Уровни залегания пузыря по отношению к эпидермису при пузырчатке:
1. внутриэпидермальное
2. субэпидермальное
3. внутридермальное
4. внутригиподермальное

255. Элементы свойственные вульгарной пузырчатке:
1. папулы
2. пузыри
3. эрозии
4. волдыри

256. При вульгарной пузырчатке обнаруживаются:
1. отложение IgG в межклеточном веществе и клетках шиповатого слоя
2. отложения IgG в области базальной мембраны
3. отложения иммунных комплексов под базальной мембраной
4. зеленое свечение (лампа Вуда)

257. Кожа вокруг пузырей при пузырчатке:
1. гиперемирована
2. не изменена
3. инфильтрирована
4. с фиолетовым оттенком

258. Пузыри при пузырчатке имеют:
1. дряблую покрышку
2. плотную покрышку

259. Положительный симптом Никольского наблюдается при:
1. экземе
2. синдроме Лайелла
3. герпетиформном дерматите Дюринга
4. истинной пузырчатке

260. Симптом Никольского первой степени:
1. отслойка эпидермиса при потягивании за край покрышки
2. расползание пузыря при надавливании на верхушку

261. Симптом Никольского второй степени:
1. грушевидная форма пузырей
2. отслойка видимо здоровой кожи между пузырями
3. отслойка эпидермиса при потягивании за край покрышки

262. Симптом Никольского третьей степени:
1. отслойка видимо здоровой кожи между пузырями
2. отслойка видимо здоровой кожи вдали от пузырей
3. краевая отслойка

263. Чтобы получить симптом Асбо-Хансена необходимо:
1. надавить на пузырь
2. вскрыть покрышку пузыря
3. потянуть за покрышку пузыря
4. потереть между пузырями

264. Для подтверждения вульгарной пузырчатки применяют методы исследования:
1. мазки - отпечатки
2. биопсию
3. содержимое пузыря на эозинофилы
4. РИФ на иммуноглобулины

265. Для лечения пузырчатки применяют:
1. антибиотики
2. глюкокортикоидные гормоны

3. препараты железа
4. антигистаминные

266. К осложнения кортикостероидной терапии относят:
1. синдром Иценко-Кушинга
2. остеопароз
3. артериальну гипертензию
4. сахарный диабет

267. Себорейная пузырчатка включает в себя следующие симптомы:
1. красной волчанки, себорейного дерматита и пузырчатки
2. красного плоского лишая, васкулита и пузырчатки
3. красной волчанки, дерматомиозита и пузырчатки
4. склеродермии, псориаза и пузырчатки

268. Пузырчатка отличается от дерматита Дюринга:
1. сильным зудом
2. напряженными пузырями
3. группировкой пузырей
4. положительным симптомом Никольского

269. Для болезни Дюринга характерно:
1. наличие истинного полиморфизма
2. положительный симптом Никольского
3. склонность высыпаний к группировке
4. положительная чувствительность к йоду

270. Для дерматита Дюринга не характерны:
1. полиморфизм сыпи
2. группировка элементов и зуд
3. акантолитические клетки
4. положительный симптом Никольского

271. Полиморфизм высыпаний характерен для:
1. вульгарной пузырчатки
2. буллезного пемфигоида
3. болезни Дюринга
4. листовидной пузырчатки

272. Для дерматита Дюринга характерны пузыри:
1. вялые
2. напряженные
3. на слизистой рта
4. на воспаленной коже

273. Укажите место расположения полости пузыря при дерматите Дюринга:
1. интраэпидермально
2. субэпидермально
3. субкорнеально

274. Дерматоз, для которого имеет диагностическое значение положительная проба с йодом:
1. вульгарная пузырчатка
2. дерматит Дюринга
3. буллезный пемфигоид
4. семейная пузырчатка

275. Лабораторными тестами для диагностики болезни Дюринга являются:
1. эозинофилия в крови и пузырной жидкости
2. клетки Тцанка в мазках отпечатках со дна эрозий
3. клетки Сезари
4. симптом дамского каблучка

276. При дерматите Дюринга назначается лечение:
1. глюкокортикоидные гормоны
2. сульфоновые препараты
3. цитостатики
4. ПУВА - терапия

277. Кроме кожи при рубцующемся пемфигоиде поражаются:
1. кожные складки
2. волосистая часть головы
3. слизистая конъюнктивы
4. ногтевые пластинки

278. Пемфигоиды отличаются от истинной пузырчатки:
1. доброкачественным течением
2. локализацией поражения
3. отрицательным симптомом Никольского
4. анемией

279. Псориаз:
1. наследуется по аутосомно-доминантному типу
2. не является наследственным заболеванием
3. развивается после психической травмы
4. является заболеванием с Х-сцепленным типом наследования

280. В развитии псориаза играют роль факторы:
1. наследственный
2. нервно-эндокринный
3. дефицит железа
4. обменный

281. Какие первичные элементы наблюдаются при псориазе:
1. узелок
2. волдырь
3. пузырь
4. бугорок

282. Вторичные морфологические элементы при псориазе:
1. чешуйки
2. корки
3. пятна
4. вегетации

283. При псориазе поражаются:
1. кожа
2. пушковые волосы
3. ногти
4. суставы

284. Перечислите сезонные форма псориаза:
1. зимний тип
2. летний
3. внесезонный

285. Клинические формы псориаза:
1. экзематозная
2. вульгарная
3. артропатическая
4. экссудативная

286. Укажите тяжелые разновидности псориаза:
1. эритродермия
2. вульгарный псориаз

3. артропатический
4. каплевидный псориаз

287. В течении псориаза выделяют следующие стадии:
1. прогрессирующая
2. стационарная
3. регрессирующая

288. При псориазе папулы бывают:
1. милиарные папулы
2. лентикулярные папулы
3. нуммулярные папулы
4. бляшки
5. папуллезные высыпания в виде дуг и гирлянд

289. Типы поражения ногтевых пластинок при псориазе:
1. в виде наперстка (симптом Геллера)
2. онихогрифоз
3. онихолизис
4. ногти никогда не поражаются

290. Ногтевые пластинки поражаются при:
1. розовом лишае
2. красном плоском лишае
3. крапивница
4. псориаз

291. Псориаза ногтей проявляется:
1. изменением окраски ногтевой пластинки
2. деформацией ногтевой пластинки
3. наперстковидной дистрофией
4. ноготь по типу когтя хищной птицы

292. К разновидностям псориаза не относятся:
1. артропатический
2. экссудативный
3. бородавчатый
4. ихтиозеформный

293. Мономорфные папулезные высыпания наблюдаются при:
1. истинной пузырчатке
2. красном плоском лишае
3. герпетиформном дерматите Дюринга
4. псориазе

294. При артропатическом псориазе поражаются:
1. подкожный жировой слой
2. эпидермис, дерма, суставы и кости
3. ногти
4. волосы

295. При псориатической эритродермии обычно:
1. температура тела снижена
2. общее состояние не нарушено
3. при длительном течении возможно поражение внутренних органов

296. Симптом Пильнова при псориазе это:
1. ярко–красная окраска папул
2. атрофический ободок вокруг папул
3. изоморфная реакция кожи
4. шелушение в центре папул

297. Основными признаками прогрессирующей стадии псориаза являются:

1. появление мелких папул
2. наличие псевдоатрофического ободка Воронова
3. положительные феномены "псориатической триады"
4. положительная изоморфная реакция Кебнера

298. Основными признаками регрессирующей стадии псориаза являются:
1. наличие псевдоатрофического ободка Воронова
2. появление милиарных папул
3. рассасывание папул в центре
4. положительные феномены псориатической триады

299. Основные патогистологические процессы в коже при псориазе:
1. нарушение деления кератиноцитов
2. нарушение кератинизации
3. воспаление
4. гиперкератоза

300. При гроттаже (поскабливании) папул при псориазе выявляют:
1. симптом скрытого шелушения
2. псориатическую триаду феноменов
3. симптом дамского каблучка
4. симптом «булыжной мостовой»

301. «Псориатическая триада» включает:
1. симптом «точечного кровотечения»
2. симптом «стеаринового пятна»
3. симптом «облатки»
4. симптом «терминальной пленки»

302. Что является морфологической основой феномена "стеаринового пятна":
1. гиперкератоз
2. паракератоз
3. акантолиз
4. спонгиоз

303. Что является морфологической основой феномена "терминальной пленки":
1. акантолиз
2. спонгиоз
3. акантоз
4. балонирующая дегенерация

304. Что является морфологической основой феномена "кровяной росы":
1. папилломатоз
2. расширение сосочков дермы
3. гиперкератоз
4. паракератоз

305. Положительная изоморфная реакция Кебнера это:
1. появление свежих папул на месте травмы через 7-14 дней
2. феномен "стеаринового пятна"
3. феномен "скрытого шелушени"
4. ободок Воронова

306. Болезнь Рейтера отличается от псориатического артрита:
1. нет уретропростатита и конъюнктивита
2. не бывает сакроилеита
3. не бывает поражения позвоночника

307. При лечении псориаза не применяют:
1. гипосенсибилизирующие препараты
2. седативные препараты
3. витамины

4. противовирусные средства

308. Кортикостероиды назначаются при следующих формах псориаза:
1. эритродермия
2. артропатия
3. пустулезный
4. вульгарный

309. В прогрессирующую стадию псориаза назначаются:
1. антигистаминные препараты
2. витамины группы В
3. тиосульфат натрия
4. общее УФО

310. При артропатическом псориазе целесообразно назначить:
1. антибиотики
2. нестероидные противовоспалительные средства
3. дезинтоксикационую терапию
4. антиоксиданты

311. Средства, применяемые для местного лечения псориаза:
1. нафталановая мазь
2. салициловая мазь
3. низораловая мазь
4. серная мазь (33%)

312. УФО при вульгарном псориазе показано в:
1. стационарной стадии
2. регрессирующей стадии
3. прогрессирующей стадии
4. не показано

313. Теории возникновения красного плоского лишая:
1. неврогенная
2. вирусная
3. бактериальная
4. эндокринная

314. Клинические разновидности красного плоского лишая:
1. типичная форма
2. бородавчатая форма
3. гипертрофическая форма
4. зостериформная форма

315. Наиболее типичные места локализации высыпаний при красном плоском лишае:
1. волосистая часть головы
2. сгибательная поверхность лучезапястного сустава
3. лицо
4. слизистые

316. При красном плоском лишае поражаются:
1. кожа
2. суставы
3. слизистые
4. ногти

317. Для высыпаний при красном плоском лишае характерно:
1. полигональная папула
2. в центре элемента — пупковидное вдавление
3. сетка Уикхема
4. восковидный блеск
5. зуд

318. Диагностические феномены красного плоского лишая:
1. кебнера
2. яблочного желе
3. ядассона
4. сетка Уикхема

319. Полигональные блестящие папулы с пупкообразным вдавление наблюдаются при:
1. красном плоском лишае
2. псориазе
3. вторичном рецидивирующем сифилисе
4. вторичном свежем сифилисе

320. Патоморфологические изменения при красном плоском лишае:
1. гипергранулез
2. акантолизис
3. отек сосочкового слоя дермы
4. эндо-, мезо-, периартериит

321. Сетка Уикхема наблюдается при:
1. красном плоском лишае
2. дискоидной красной волчанке
3. псориазе
4. центробежной эритеме Биетта

322. Реакция Кебнера наблюдается при:
1. хронической красной волчанке
2. красном плоском лишае
3. центробежной эритеме Биетта
4. псориазе

323. К немедикаментозным способам лечения красного плоского лишая относятся:
1. рефлексотерапия
2. хирургическое удаление ногтевых пластинок
3. гипноз
4. электросон

324. При розовом лишае первичный элемент:
1. бугорок
2. папула
3. пятно
4. везикула

325. Розовый лишай локализуется преимущественно на:
1. волосистой части головы
2. голенях
3. туловище, по линиям натяжения кожи
4. стопах

326. Для лечения розового лишая целесообразно назначать:
1. гипосенсибилизирующую терапию
2. гормоны
3. противогрибковые антибиотики
4. лидазу

327. Укажите облигатные предраковые болезни:
1. болезнь Боуэна
2. пигментная ксеродерма
3. лейкоплакия
4. эритроплазия Кейра

328. Укажите факультативные предраковые болезни:

1. акнический хейлит
2. болезнь Педжета
3. трофическая язва
4. хроническая трещина нижней губы

329. Укажите злокачественные опухоли:
1. базалиома
2. кератоакантома
3. меланома
4. ботриогранулема

330. Для лечения лимфом применяют:
1. кортикостероиды
2. цитостатики
3. лучевую терапию
4. препараты цинка

331. Эритроплазию Кейра дифференцируют с:
1. кандидозным баланопоститом
2. твердым шанкром
3. герпесом
4. мягким шанкром

332. Базалиома чаще локализуется на:
1. ладонях
2. лице
3. туловище
4. бедрах

333. Базально-клеточную эпителиому дифференцируют с:
1. спиноцеллюлярным раком
2. экземой
3. хронической красной волчанкой
4. псориазом

334. При хронической красной волчанке поражаются:
1. почки
2. печень
3. ц.н.с
4. кожа

335. Симптомы хронической красной волчанки:
1. гиперкератоз
2. эритема
3. атрофия
4. мокнутие

336. Типичная локализация хронической волчанки:
1. лицо
2. ладони
3. ушные раковины
4. волосистая часть головы

337. Для диссеминированной формы красной волчанки характерны:
1. распространенный характер сыпи
2. небольшие очаги поражения
3. лихенизация
4. поражения закрытых участков кожи

338. Для центробежной эритемы характерны:
1. эритема
2. фолликулярный гиперкератоз

3. атрофия

339. Для лечения хронической красной волчанки применяют:
1. УФО
2. препараты резохинового ряда
3. кортикостероиды
4. антибиотики

340. В системную красную волчанку чаще переходит:
1. дискоидная красная волчанка
2. центорбежная эритема Биетта
3. диссеминированная красная волчанка

341. В настоящее время красную волчанку относят к:
1. инфекционным заболеваниям
2. аутоиммунным заболеваниям
3. вирусным заболеваниям
4. венерическим болезням

342. О переходе хронической красной волчанки в системную говорит:
1. LE- феномен
2. ускорение СОЭ
3. альбуминурия
4. лейкопения

343. Диагностические симптомы дискоидной красной волчанки:
1. симптом Никольского
2. симптом Бенье-Мещерского
3. симптом “дамского каблучка”
4. симптом “ кровяной росы”

344. Излюбленная локализация дискоидной красной волчанки:
1. туловище
2. лицо
3. ушные раковины
4. волосистая часть головы

345. Дифференционный диагноз дискоидной красной волчанки проводят с:
1. псориазом
2. туберкулезной волчанкой
3. простым контактным дерматитом
4. красным плоским лишаем

346. Очертания бабочки характерны для:
1. дискоидной красной волчанки
2. ценробежной эритемы Биетта
3. диссеминированной красной волчанки
4. витилиго

347. Для местного лечения красной волчанки применяются
1. мази с антибиотиками
2. стероидные мази
3. салициловая мазь
4. противогрибковые мази

348. Дискоидная красная волчанка заканчивается:
1. рубцеванием
2. пигментным пятном
3. проходит бесследно
4. трансформируется в лимфому

349. Для склеродермии характерны стадии:
1. отека

2. атрофии
3. шелушения
4. уплотнения

350. Для лечения склеродермии применяют:
1. УФО
2. антибиотики
3. лидазу
4. кортикостероиды

351. Для дерматомиозита характерны:
1. гипертрофия мышц
2. гемосидероз
3. креатинурия
4. анемия

352. Клинические проявления дерматомиозита:
1. периорбитальный отек
2. мышечная слабость
3. адинамия
4. эритематозно-сквамозная сыпь

353. Для лечения дерматомиозита применяют:
1. кортикостероиды
2. препараты кальция
3. транквилизаторы
4. антистафилококковый иммуноглобулин

354. Для лечения очаговой склеродермии применяют:
1. примочки
2. УФО
3. парафин
4. ПУВА - терапию

355. Бляшечная склеродермия заканчивается:
1. рубцевой атрофией
2. пигментным пятном
3. проходит бесследно
4. присоединением вторичной инфекции

356. Первичные морфологические элементы при туберкулезной волчанке:
1. бугорки
2. язвы
3. узлы
4. папулы

357. Назовите локализованные формы туберкулеза кожи:
1. лихеноидный
2. бородавчатый
3. индуративный
4. колликвативный

358. Для туберкулезной волчанки характерны:
1. симптом Поспелова
2. симптом «стеаринового пятна»
3. симптом «яблочного желе»
4. симптом Бенье-Мещерского

359. Папуло-некротический туберкулез локализуется на:
1. лице
2. волосистой части головы
3. голенях

4. подошвах

360. Папуло - некротический туберкулез дифференцируют от:
1. многоформной экссудативной эритемы
2. почесухи
3. псориаза
4. скрофулодермы

361. Туберкулезную волчанку дифференцируют от:
1. дискоидной красной волчанки
2. бугоркового сифилида
3. лепры
4. индуративной эритемы Базена

362. Скрофулодерма чаще локализуется:
1. область шеи
2. паховая область
3. бедра
4. туловище

363. Скрофулодерму необходимо дифференцировать от:
1. гуммозного сифилида
2. лейшманиоза
3. лепры
4. простого герпеса

364. Бородавчатый туберкулез чаще локализуется на:
1. туловище
2. тыле кистей
3. волосистой части головы
4. ладонях

365. Для туберкулезной волчанки характерны:
1. эпителиоидные клетки
2. гигантские клетки (Лангханса)
3. лимфоциты
4. плазматические клетки

366. Индуративную эритему Базена дифференцируют с:
1. геморрагическим васкулитом
2. узловатой эритемой
3. лепрой
4. третичным сифилисом

367. Микобактерии туберкулеза попадают в кожу:
1. гематогенным путем
2. лимфогенным путем
3. воздушно-капельным путем
4. трансплацентарно

368. Диагноз туберкулеза кожи ставят на основании:
1. туберкулиновых проб
2. биопсии кожи
3. флюорографии легких
4. всех выше перечисленных методов

369. Туберкулез кожи лечат:
1. пенициллином
2. тетрациклином
3. рифампицином
4. герпевиром

370. Узловатая эритема Базена локализуется на:

1. лице
2. туловище
3. голенях
4. волосистой части головы

371. Рубцы после туберкулезной волчанки:
1. мозаичные
2. звездчатые
3. по типу “ смятой папиросной бумаги”

372. Рубцы после скрофулодермы:
1. звездчатые
2. мозаичные
3. мостовидные

373. Язвенный туберкулез кожи локализуется на:
1. бедрах
2. туловище
3. у естественных отверстий

374. При бородавчатом туберкулезе микобактерия попадает в кожу:
1. гематогенным путем
2. лимфогенным путем
3. через поврежденную кожу

375. Бородавчатый туберкулез кожи дифиринцирует с:
1. хронической пиодермией
2. аллергическим дерматитом
3. псориазом

376. Лихеноидный туберкулез относится к:
1. локализованным формам
2. диссеменированным формам

377. Для городского типа лейшманиоза характерно:
1. длительный инкубационный период
2. хроническое течение
3. сезонность заболевания
4. короткий инкубационный период

378. Источником заражения сельским типом лейшманиоза являются:
1. больные кошки
2. грызуны
3. крупный рогатый скот
4. больные люди

379. Для кожного лейшманиоза характерны стадии:
1. пятна
2. бугорков
3. уплотнения
4. рубцевания

380. Методы лабораторной диагностики лейшманиоза:
1. микроскопия
2. посев на питательную среду
3. гистологический
4. проба с аллергеном

381. Меры профилактики лейшманиоза:
1. вакцинация
2. борьба с грызунами
3. применение репеллентов
4. противомоскитные сетки

382. Источники заражения городским типом являются:
1. грызуны
2. крупный рогатый скот
3. больные люди
4. кошки, собаки

383. Переносчиками лейшманий являются:
1. москиты
2. больные животные
3. больные люди
4. грызуны

384. Для клиники лейшманиоза характерны:
1. бугорок
2. язва
3. рубец
4. все выше названные

385. В лечении лейшманиоза используют:
1. гормоны
2. антибиотики
3. сульфаниламидные препараты
4. противогрибковые препараты

386. Клинические формы лепры:
1. лепроматозная
2. индуративная
3. недифференцированная
4. туберкулоидная

387. Пути заражения лепрой:
1. половой
2. воздушно-капельный
3. через кровососущих насекомых
4. через поврежденную кожу

388. Возбудитель лепры:
1. простейшие
2. микобактерии
3. спирохеты
4. вирусы

389. Субъективные расстройства при лепре:
1. парастезии
2. нарушение температурной чувствительности
3. нарушение болевой чувствительности
4. нарушение тактильной чувствительности

390. Для лечения лепры могут применяться:
1. сульфоновые препараты
2. антибиотики
3. иммуномодуляторы
4. гормоны

391. Инкубационный период при лепре:
1. несколько дней
2. несколько месяцев
3. несколько лет
4. несколько часов

392. Микобактерии лепры ищут:
1. в мократе

2. в кале
3. в соскобе со слизистой носа
4. в моче

393. Клинические тесты при лепре:
1. проба с гистамином
2. иодно - крахмальная проба (Минора)
3. проба Ядассона
4. проба Бальцера

394. При лепроматозном типе лепры:
1. узлы
2. бугорки
3. папулы
4. пятна

395. При туберкулоидном типе лепры:
1. пятна
2. папулы
3. узлы
4. волдыри

396. Проба с лепромином при лепроматозном типе:
1. положительная
2. отрицательная

397. У здоровых людей проба с лепромином:
1. положительная
2. отрицательная

398. Нарушение чувствительности наступает раньше при:
1. туберкулоидном типе лепры
2. лепроматозном типе лепры
3. недифиринцированном типе лепры

399. Лепроматозный тип лепры дифференцирует с:
1. псориазом
2. красным плоским лишаем
3. гуммозным сифилидом
4. розовым лишаем

400. Туберкулоидный тип лепры дифференцирует:
1. витилиго
2. красным плоским лишаем
3. бугорковым сифилидом
4. бляшечной склеродермией

401. Мутиляция пальцев бывает при:
1. лепроматозном типе лепры
2. туберкулоидном типе лепры
3. недифферинцированном типе лепры

402. Простой контактный дерматит может возникнуть на воздействие:
1. кислот, щелочей
2. высокой температуры
3. косметических средств
4. стиральных порошков

403. Аллергический дерматит возникает при воздействии:
1. стиральных порошков
2. косметических средств
3. концентрированных кислот и щелочей
4. высоких и низких температур

404. Проявление простого контактного дерматита:
1. эритема
2. пузыри
3. папулы
4. волдыри

405. Проявление аллергического дерматита:
1. эритема
2. пузыри
3. папулы
4. гнойнички

406. Простой контактный дерматит возникает через:
1. несколько минут
2. несколько дней

407. Аллергический дерматит возникает через:
1. несколько минут
2. несколько часов
3. несколько дней

408. Аллергический дерматит возникает при воздействии аллергена:
1. на кожу
2. прием внутрь

409. Для лечения аллергического дерматита используют:
1. антигистаминные препараты
2. антибиотики
3. стероидные гормоны
4. противогрибковые препараты

410. Токсикодермии вызывают:
1. медикаменты
2. продукты питания
3. укусы насекомых

411. Для токсикодермии характерны:
1. пузыри
2. волдыри
3. бугорки
4. узлы

412. В лечении токсикодермии применяют:
1. антигистаминные препараты
2. гипосенсибилизирующие препараты
3. стероидные гормоны

413. Тяжелой формой токсикодермии является:
1. сидром Лайелла
2. синдром Стивенсан-Джонсона

414. Для синдрома Лайелла характерны:
1. пузыри
2. эрозии
3. волдыри

415. При синдроме Лайелла симптом Никольского:
1. отрицацельный
2. положительный

416. Первичные элементы при истинной экземе:
1. бугорки
2. пятна
3. папулы

4. везикулы

417. В основе экземы лежат патогистологические изменения:
1. паракератоз
2. спонгиоз
3. акантолизис
4. вегетация

418. Себорейная экзема локализуется на коже:
1. спины
2. лица
3. нижних конечностей
4. волосистой части головы

419. Для истинной экземы характерны:
1. симметричность очагов
2. асимметричность
3. четкие границы
4. «архипелаг островов»

420. Для микробной экземы характерны:
1. асимметричность очагов
2. четкие границы
3. симметричность очагов

421. Частая локализация микробной экземы:
1. лицо
2. туловище
3. нижние конечности

422. В лечении экземы используют:
1. антигистаминные препараты
2. десенсибилирующие препараты
3. витамины

423. Факторы, способствующие развитию профессиональных болезней кожи:
1. смолы
2. растворители
3. спирт
4. известь

424. Разновидности профдерматозов, вызываемых производственными аллергенами:
1. профессиональная экзема
2. профессиональная токсикодермия
3. профессиональная крапивница
4. розовый лишай

425. Профдерматозы, вызываемые инфекционными и паразитарными агентами: эризепелоид
1. глубокая трихофития
2. красный плоский лишай
3. кандидозы

426. Производственными аллергенами могут быть:
1. синтетический клей
2. антибиотики
3. краски
4. эпоксидные смолы

427. Для профессионального дерматоза характерно:
1. локализация поражений на открытых участках кожи
2. положительные результаты кожных аллергических проб

3. подобные поражения кожи у других, работающих на данном технологическом процессе
4. выздоровление во время отпуска

428. Для подтверждения диагноза профдерматоза необходима документация:
1. выписка из амбулаторной карты
2. санитарно-гигиеническая характеристика рабочего места
3. служебная характеристика больного
4. выписка из трудовой книжки

429. Меры профилактики профдерматозов:
1. автоматизация производства
2. спецодежда
3. вентиляция
4. чистота рабочего места

430. Для витилиго характерны первичные элементы:
1. папула
2. волдырь
3. пятно депигментации
4. узел

431. В патогене витилиго имеют значение:
1. болезни легких
2. болезни щитовидной железы
3. нарушения нервной системы
4. недостаточность гипофизарно-надпочечниковой системы

432. Дифференциальный диагноз витилиго проводится с:
1. сифилитической лейкодермой
2. розовым лишаем
3. отрубевидным лишаем
4. туберкулезом кожи

433. Для лечения витилиго применяют:
1. препараты цинка, меди, железа
2. меладинин
3. кортикостероиды
4. ПУВа - терапия

434. В очагах витилиго:
1. нарушается чувствительность
2. выпадают волосы
3. обесцвечиваются волосы

435. Витилиго дифференцируют с:
1. лепроматозным типом лепры
2. туберкулоидным типом лепры
3. недифференцированным типом лепры

436. Алопеция может быть при:
1. псориазе
2. сифилисе
3. истинной экземе
4. красной волчанке

437. При алопеции целесообразно провести исследования:
1. серологические на сифилис, ВИЧ
2. анализ мочи на 17-кетостероиды
3. содержание цинка, меди, железа
4. иммунологические

438. При алопеции проводятся инструментальные исследования:

1. эхоэнцефалография
2. рентгенография костей голени
3. рентгенография турецкого седла
4. реовазография сосудов головного мозга

439. Для лечения алопеции применяют:
1. препараты цинка, меди, железа
2. антибиотики
3. биогенные стимуляторы
4. физиотерапевтические средства

440. Гнездную алопецию дифференцирует с:
1. грибковыми заболеваниями волосистой части головы
2. сифилитической алопецией
3. красной волчанкой

441. Причины гнездной алопеции:
1. глистная инвазия
2. хронический тонзиллит
3. нарушение обмена меди в организме

442. Гнездная алопеция бывает чаще у:
1. детей до 14 лет
2. подростков
3. взрослых

443. Локализация гнездной алопеции:
1. волосистая часть головы
2. брови
3. область бороды и усов

444. Возбудитель сифилиса:
1. Treponema pallidum
2. Treponema balanitidis
3. Treponema pertenue
4. Treponema caratea

445. Бледная трепонема была открыта:
1. в 1901 году
2. в 1889 году
3. в 1905 году
4. в 1926 году

446. Бледная трепонема была открыта:
1. Шаудином
2. Гофманом
3. Вассерманом
4. Нейссером

447. Бледная трепонема:
1. имеет спиралевидную форму
2. является диплококком
3. одноклеточный организм грушевидной формы
4. стрептобацилла
5. плохо окрашивается анилиновыми красителями

448. Виды движения спирохеты:
1. сгибательное
2. поступательное
3. волнообразное
4. прыгающее
5. маятникообразное

449. Срок деления патогенной бледной трепонемы составляет:
1. 6-8 ч
2. 10-12 ч
3. 15-20 ч
4. 30-33 ч
5. 35-40 ч

450. Длина бледной трепонемы в среднем составляет:
1. 6-20 мкм
2. 50-60 мкм
3. 30-40 мкм
4. 40-50 мкм

451. Число оборотов спирали бледной трепонемы составляет:
1. 2-4
2. 6-8
3. 8-14
4. 16-20

452. В лабораторных условиях сифилис вызывается у следующих животных:
1. кроликов
2. морских свинок
3. собак
4. крыс
5. человекообразных обезьян

453. Варианты течения приобретенного сифилиса:
1. инкубационный период- первичный период – вторичный период – третичный период – поздние формы
2. длительное бессимптомное течение – скрытый поздний сифилис – поздние формы сифилиса
3. инкубационный период - первичный период – вторичный период – случаи самоизлечения
4. длительное бессимптомное течение - вторичный период – третичный период – поздние формы

454. Для сифилиса характерны следующие пути передачи:
1. половой
2. трансмиссивный
3. вертикальный
4. трансфузионный
5. бытовой

455. Физиологические секреты и экскреты, которые могут быть заразны при сифилисе:
1. слюна
2. пот
3. моча
4. грудное молоко
5. сперма

456. Бледные трепонемы можно обнаружить:
1. в твердом шанкре
2. в бугорковых сифилидах
3. в эрозивных папулах
4. в фиброзных гуммах

457. Какой микроскопический метод обнаружения бледной трепонемы является наилучшим:
1. обычный

2. темнопольный
3. люминисцентный

458. Укажите, какие формы может образовывать бледная трепонема при неблагоприятных условиях в организме человека (прием антибиотиков и т.д.):
1. Цисты
2. L-формы
3. Биполярные формы
4. Фильтрующиеся формы

459. Инкубационный период при сифилисе:
1. Составляет 4 недели
2. Составляет 3-5 дней
3. Может удлиняться
4. Составляет 6 – 12 недель
5. Может укорачиваться

460. Причины удлинения инкубационного периода сифилиса:
1. прием антигистаминных препаратов
2. прием антибиотиков
3. авитаминоз
4. прием кортикостероидов
5. иммунодефицит

461. Инкубационный период сифилиса укорачивается:
1. у наркоманов
2. у молодых, физически крепких лиц
3. у лиц с иммунодефицитом
4. после приема антибиотиков

462. Укорочение инкубационного периода сифилиса наблюдается:
1. при развитии одиночного твердого шанкра
2. при биполярном расположении твердых шанкров
3. при развитии множественных твердых шанкров
4. при развитии эрозивных твердых шанкров
5. при развитии язвенных твердых шанкров

463. Для первичного периода сифилиса характерно:
1. появление сыпи на туловище и конечностях
2. образование твердого шанкра
3. увеличение всех групп лимфоузлов
4. увеличение регионарных лимфоузлов

464. Критерии постановки диагноза первичного серопозитивного сифилиса:
1. клиническая картина
2. обнаружение бледной трепонемы
3. положительные серореакции
4. отрицательные серореакции

465. Обезглавленный сифилис возможен при:
1. переливании крови больного
2. позднем врожденном сифилисе
3. неполноценном превентивном лечении
4. наличии экстрагенитальных шанкров

466. После контакта с больным сифилисом твердый шанкр появляется спустя:
1. 1 неделю
2. 2 недели
3. 4 недели
4. 6-7 недель
5. 8-9 недель

467. Твердый шанкр может осложниться:

1. фимозом
2. парафимозом
3. эктимой
4. баланитом
5. вульвовагинитом

468. С какого периода начинается "трансфузионный" сифилис:
1. с первичного
2. с вторичного
3. с третичного
4. с врожденного

469. Для твердого шанкра не характерны:
1. болезненность
2. четкие границы
3. уплотнение в основании
4. гнойное отделяемое

470. К атипичным твердым шанкрам относятся:
1. индуративный отек
2. широкие кондиломы
3. шанкр-панариций
4. фликтена
5. баланит Фольмана

471. Для регионарного лимфаденита в первичном периоде сифилиса характерно:
1. безболезненность
2. спаянность между собой
3. воспаление кожи
4. плеяда Рикора

472. Какая примочка применяется перед забором материала с поверхности твердого шанкра:
1. примочка с азотнокислым серебром
2. примочка с физиологическим раствором
3. примочка с борной кислотой

473. При какой локализации первичной сифиломы может отмечаться болезненность:
1. в области уздечки
2. в области ануса
3. при шанкре-панариции

474. Как называются разновидности шанкров, если их несколько:
1. множественные
2. биполярные
3. шанкры-отпечатки
4. кавернозные

475. При сифилисе материал для исследования на бледную трепонему берется из:
1. твердого шанкра
2. эрозивных папулезных сифилидов
3. регионарных лимфатических узлов
4. бугорковых сифилидов
5. розеолы

476. Разновидности первичного периода сифилиса:
1. серонегативный
2. первичный скрытый
3. серопозитивный
4. первичный активный
5. обезглавленный

477. Различают твердые шанкры:
1. эрозивный
2. пятнистый
3. пустулезный
4. язвенный

478. Рубец после заживления твердого шанкра называется:
1. печатью Каина
2. печатью дьявола
3. шанкром-отпечатком
4. звездчатым

479. Шанкр-панариций представляет из себя:
1. эрозию или язву на пальцах кистей
2. увеличенную в объеме пораженную фалангу без дефекта на ее поверхности и признаков воспаления
3. увеличенную в объеме пораженную фалангу с дефектом на ее поверхности и признаками воспаления

480. Твердый шанкр необходимо дифференцировать с:
1. гипоспадией
2. мягким шанкром
3. герпесом
4. шанкриформной пиодермией

481. Для мягкого шанкра характерно:
1. Появление единичной эрозии мясо-красного цвета с плотноэластическим основанием
2. Появление множественных язв с подрытыми краями, покрытых гнойным отделяемым
3. Отсутствие субъективных ощущений
4. Наклонность к аутоинокуляции
5. Правильные округлые очертания

482. На основании каких признаков выставляется диагноз I сифилиса:
1. конфронтации
2. серологических данных
3. реакции иммобилизации бледных трепонем
4. обнаружении спирохеты
5. клинических проявлений

483. Как называется повторное заражение сифилисом:
1. реинфекция
2. суперинфекция
3. реакция Яриша-Лукашевича-Герксгеймера
4. иммуноблоттинг

484. Реакция Вассермана после заражения сифилисом станет положительной через:
1. 3-4 недели
2. 6-8 недель
3. 9-12 недель
4. 2-4 года

485. Наиболее специфичным серологическим тестом на сифилис является:
1. реакция иммунофлюоресценции
2. реакция иммобилизации трепонем
3. реакция Вассермана
4. микрореакция

486. Реакция иммобилизации бледных трепонем производится с целью:
1. подтверждения диагноза первичного сифилиса
2. подтверждения диагноза скрытого сифилиса
3. подтверждения диагноза вторичного свежего сифилиса
4. контроля за лечением
5. решения вопроса о снятии больного с учета

487. Увеличение регионарных лимфоузлов после появления твердого шанкра наблюдается обычно спустя:
1. 1-2 дня
2. 5-8 дней
3. 9-12 дней
4. 13-16 дней
5. 21 день

488. Основными препаратами для лечения больных сифилисом являются:
1. препараты пенициллина
2. препараты тетрациклина
3. препараты эритромицина
4. макролиды

489. К побочным явлениям при лечении сифилиса пенициллином относятся все перечисленные, кроме:
1. анафилактического шока
2. токсидермии
3. крапивницы
4. кандидоза
5. алопеции

490. Какие пенициллины пролонгированного действия применяются для лечения сифилиса:
1. бициллин
2. экстенциллин
3. тетрациклин
4. азитромицин
5. сульфадиметоксин

491. Какие препараты применяются для неспецифической терапии сифилиса:
1. пирогенал
2. ретиноиды
3. витамины
4. биогенные стимуляторы
5. глюкокортикоиды

492. Иммунитет при сифилисе:
1. инфекционный
2. стерильный
3. нестерильный
4. противошанкерный

493. Вторичный период сифилиса начинается с момента заражения через:
1. 2 недели
2. 2 месяца
3. 3 месяца
4. 6 месяцев

494. Вторичный период сифилиса делится на:
1. свежий
2. манифестный
3. скрытый
4. активный
5. рецидивный

495. Для вторичного сифилиса характерно все перечисленное, кроме:

1. наличия островоспалительных явлений
2. поражения ладоней и подошв
3. отсутствия островоспалительных явлений
4. полиаденита
5. зуда очагов

496. Вторичные сифилиды слизистых оболочек:
1. Встречаются редко
2. Наблюдаются в виде папулезных и пятнистых высыпаний
3. Имеются нечеткие границы
4. Малоконтагиозны

497. После появления твердого шанкра вторичный период сифилиса наступает, в среднем, через:
1. 5-6 недель
2. 6-7 недель
3. 6-8 недель
4. 8-9 недель

498. Для вторичного периода характерны высыпания:
1. узлов
2. розеол
3. папул
4. пустул
5. везикул

499. Для вторичного свежего сифилиса характерно:
1. скудность высыпаний
2. остатки твердого шанкра
3. выраженная реакция Яриша-Лукашевича-Герксгеймера
4. папулезная сыпь
5. розеолезная сыпь

500. Разновидности сифилитических розеол:
1. милиарные
2. элевирующие
3. геморрагические
4. сливные
5. фолликулярные

501. Сифилитическую розеолу необходимо дифференцировать с:
1. краснухой
2. брюшным тифом
3. токсидермией
4. псориазом
5. розовым лишаём

502. Укажите разновидности папулезных сифилидов:
1. псориазиформные
2. угревидные
3. ладонно-подошвенные
4. нуммулярные
5. вегетирующие (широкие кондиломы)

503. Дифференциальную диагностику папулезного сифилида следует проводить со всеми перечисленными заболеваниями, кроме:
1. красного плоского лишая
2. каплевидного парапсориаза
3. листовидной пузырчатки
4. псориаза

5. фолликулярного гиперкератоза

504. Сифилитические папулы дифференцируют с:
1. крапивницей
2. красным плоским лишаем
3. аллергическим дерматитом
4. псориазом
5. контактным дерматитом

505. Широкие кондиломы появляются:
1. во время вторичного рецидивного сифилиса
2. через две недели после заражения
3. через 1 месяц после заражения
4. в первичный серонегативный период
5. в первичный серопозитивный период

506. Широкие кондиломы необходимо дифференцировать с:
1. остроконечными кондиломами
2. отрубевидным лишаем
3. розовым лишаем
4. крапивницей
5. сыпным тифом

507. «Корона Венеры» - это:
1. сифилитическая аллопеция
2. сифилитическая лейкодерма
3. папулы по краю роста волос на голове
4. папулы на гениталиях

508. Разновидности пустулезного сифилида:
1. угревидный (акнеформный)
2. шанкриформный
3. оспенновидный
4. эктима
5. рупия

509. Сифилитические пустулы необходимо дифференцировать с:
1. вульгарными угрями
2. ветряной оспой
3. вульгарным импетиго
4. фурункулом
5. вульгарной рупией

510. Назовите разновидности сифилитической лейкодермы:
1. сетчатая
2. геморрагическая
3. мраморная
4. уртикарная
5. кружевная

511. Сифилитическая лейкодерма возникает:
1. через 6 мес. после заражения
2. в инкубационный период
3. через 2 недели после заражения
4. в первичный серонегативный период
5. в первичный серопозитивный период

512. «Ожерелье Венеры» - это:
1. сифилитическая алопеция
2. сифилитическая лейкодерма
3. папулы по краю роста волос на голове

4. парафимоз

513. Укажите виды сифилитической алопеции:
1. диффузная
2. гнездная
3. мелкоочаговая
4. смешанная
5. субтотальная

514. Сифилитическая алопеция возникает:
1. во вторичном периоде
2. в инкубационном периоде
3. Через 2 недели после заражения
4. в первичном серонегативном периоде
5. в первичном серопозитивном периоде

515. Признак Пинкуса наблюдается при сифилитическом поражении:
1. слизистых
2. кожи
3. волос
4. ногтей
5. красной каймы губ

516. Омнибусный сифилид – это:
1. ступенеобразные ресницы
2. выпадение латеральных концов бровей и ресниц
3. папулы по краю роста волос на голове
4. разновидность пустулезного сифилида

517. К разновидностям сифилитической ангины относятся:
1. эритематозная
2. гнойно-некротическая
3. папулезная
4. лакунарная
5. пустулезная

518. Большинство вторичных сифилидов разрешаются без лечения спустя:
1. 1-2 месяца
2. 2-3 месяца
3. 3-4 месяца
4. 4-5 месяцев

519. При висцеральном сифилисе чаще всего поражается:
1. почки
2. брыжейка тонкой кишки
3. аорта
4. легкие
5. поджелудочная железа

520. РИБТ положительна у больных:
1. первичным серонегативным сифилисом
2. вторичным рецидивным
3. первичным серопозитивным
4. третичным сифилисом
5. мягким шанкром

521. Реакция Яриша-Лукашевича-Герксгеймера при сифилисе – это:
1. реакция обострения после начала антибиотикотерапии
2. регионарный лимфаденит
3. полиаденит
4. РИБТ

522. К формам скрытого сифилиса относятся все перечисленные, кроме:
1. раннего

2. позднего
3. неведомого
4. неуточненного
5. серонегативного

523. Для раннего скрытого сифилиса характерно:
1. срок предполагаемого заражения до 2-х лет
2. отсутствие высыпаний
3. низкий титр серологических реакций
4. наличие на коже высыпаний
5. срок предполагаемого заражения более 2-х лет

524. Для позднего скрытого сифилиса характерно:
1. срок предполагаемого заражения более 2-х лет
2. низкий титр серологических реакций
3. наличие высыпаний
4. отсутствие высыпаний
5. срок предполагаемого заражения до 2-х лет

525. План обследования больного со вторичным сифилисом:
1. половой анамнез
2. клинический осмотр
3. исследование на трепонему при высыпаниях
4. серологические реакции

526. В третичном периоде сифилиса выделяют следующие стадии:
1. подострую
2. прогрессирующую
3. латентную
4. стационарную
5. активную

527. Развитию третичного сифилиса способствуют:
1. алкоголизм
2. иммунодефицитные состояния
3. тяжелая сопутствующая патология
4. все верно

528. Первичные элементы, встречающиеся в третичном периоде сифилиса:
1. розеола
2. волдырь
3. бугорок
4. везикула
5. узел

529. Для диагностики третичного периода сифилиса необходимо:
1. РИФ
2. микроскопическое исследование высыпных элементов
3. РИБТ
4. культуральное исследование
5. гистологическое исследование

530. Для сифилитических бугорков характерно:
1. положительный симптом Бенье-Мещерского
2. плотная консистенция, медно-красный цвет
3. болезненность при пальпации
4. после изъязвления — "мозаичные рубцы"
5. возможность рецидивов на рубце

531. Для гуммозного сифилида характерно:
1. малая контагиозность
2. высокая контагиозность

3. плотно-эластическая консистенция
4. дно язвы кровоточит
5. наличие гуммозного стержня

532. Рубцы при бугорковом сифилиде бывают:
1. атрофические
2. мозаичные
3. мостикообразные
4. штампованные

533. Розеола Фурнье как проявление сифилиса встречается в:
1. первичном серонегативном периоде
2. вторичном рецидивном периоде
3. первичным серопозитивном периоде
4. третичном периоде

534. В основе бугорковых и гуммозных сифилидов лежит:
1. дискератоз
2. гипергранулез
3. эпидермолиз
4. инфекционная гранулема

535. Разновидности бугоркового сифилида:
1. карликовый
2. сгруппированный
3. серпигинозный
4. "площадкой"
5. вегетирующий

536. Бугорковый сифилид следует дифференцировать со всеми перечисленными заболеваниями, кроме:
1. туберкулеза кожи
2. лейшманиоза
3. лепры
4. глубоких микозов
5. экземы

537. Гуммозные поражения на коже следует дифференцировать со всеми перечисленными заболеваниями, кроме:
1. скрофулодермы
2. трофических язв
3. хронической язвенной пиодермии
4. лейшманиоза
5. парапсориаза

538. Гуммы могут локализоваться в:
1. желудочно-кишечном тракте
2. легких
3. печени
4. языке
5. мозге

539. Рубцы при третичном сифилисе имеют вид:
1. втянутых
2. звездчатых
3. поверхностных
4. плоских
5. мозаичных

540. Возможны все перечисленные исходы гуммозных сифилидов, кроме:
1. рубцовой атрофии

2. рассасывания бесследно
3. распада
4. фиброза
5. изъязвления

541. Третичный сифилис характеризуется всем перечисленным, кроме:
1. ограниченности поражения
2. фокусного расположения элементов сыпи
3. наклонности к распаду
4. образования рубцов на месте разрешившихся элементов
5. яркой окраски морфологических элементов

542. Внутриутробное заражение плода возможно, если у беременных:
1. первичный сифилис
2. вторичный сифилис
3. ранний скрытый сифилис
4. нейросифилис

543. Ранний врожденный сифилис включает следующие периоды:
1. сифилис раннего детского возраста
2. сифилис плода
3. сифилис детей грудного возраста
4. вторичный сифилис

544. Особенности сифилитической пузырчатки:
1. возникновение напряженных пузырей размером с горошину на инфильтрированном основании
2. положительный симптом Никольского
3. симметричное расположение на ладонях и подошвах
4. наличие эозинофилов в содержимом пузырей

545. Достоверный признак позднего врожденного сифилиса:
1. сифилитический ринит
2. высокое «готическое» нёбо
3. зубы Гетчинсона
4. сифилитическая пузырчатка

546. Клиническими признаками врожденного сифилиса детей грудного возраста не являются:
1. седловидный нос
2. рубцы Робинсона-Фурнье
3. ягодицеобразный череп
4. диффузная алопеция
5. все перечисленное верно

547. К достоверным клиническим признакам позднего врожденного сифилиса относят:
1. паренхиматозный кератит
2. специфический лабиринтит
3. зубы Гетчинсона
4. сифилитический ринит
5. недоразвитие мечевидного отростка грудины

548. При врожденном сифилисе раннего детского возраста выявляют:
1. папулезные сифилиды
2. широкие кондиломы
3. поражения трубчатых костей
4. зубы Гетчинсона

549. Поздний врожденный сифилис развивается:
1. на поздних сроках беременности
2. в возрасте до 1-го года
3. в возрасте до 2-х лет
4. после 2-х лет жизни

5. в период новорожденности

550. Укажите признаки сифилиса плода:
1. паренхиматозный кератит
2. дистрофия подкожной жировой клетчатки
3. увеличение печени
4. триада Гетчинсона
5. увеличение плаценты

551. Для раннего врожденного сифилиса характерны следующие проявления:
1. сифилитическая пузырчатка
2. эпидемическая пузырчатка
3. папулезная сыпь
4. саблевидные голени

552. В "триаду Гетчинсона" входят следующие признаки:
1. паренхиматозный кератит
2. зубы Гетчинсона
3. "псевдопаралич" Парро
4. сифилитический лабиринтит

553. Сифилитическое поражение плаценты проявляется:
1. отеком и пролиферацией клеточных элементов
2. наличием кальцификатов плаценты
3. увеличением массы и размеров последа
4. неизменной зародышевой частью
5. эндо-, мезо-, периартериитом

554. Основные исследования детей при подозрении на врожденный сифилис:
1. клиническое обследование
2. исследование глазного дна
3. рентген длинных трубчатых костей
4. осмотр невропатолога с обязательным исследованием ликвора
5. серологические реакции

555. Серологические реакции при подозрении на врожденный сифилис:
1. РВ
2. ИФА
3. РИБТ
4. РИФ

556. Чем характеризуется сифилитический насморк:
1. начало сразу после рождения или на 1 месяце жизни
2. развитие инфильтрации в подслизистом слое
3. затруднение дыхания
4. гнойно-кровянистое отделяемое

557. Чем характеризуется папулезная инфильтрация при раннем врожденном сифилисе:
1. начало заболевания на 8-10 неделе
2. локализация на коже ладоней, подошв, вокруг рта
3. наличие инфильтрации кожи в указанных местах
4. развитие шелушения при разрешении
5. положительные серореакции

558. Для раннего врожденного сифилиса характерно:
1. пятнистая сыпь кожи туловища
2. папулезная сыпь кожи туловища
3. сифилитический ринит
4. сифилитическая алопеция

559. Для позднего врожденного сифилиса характерно:
1. гумма твердого неба
2. паренхиматозный кератит
3. бугорки кожи туловища
4. розеола кожи туловища

560. Для позднего врожденного сифилиса характерно:
1. бугорки кожи туловища
2. лабиринтная глухота
3. гуммы кожи туловища
4. саблевидные голени

561. Для позднего врожденного сифилиса характерно:
1. ягодицеобразный череп
2. бочкообразные зубы
3. гетчинсоновские зубы
4. широко расставленные верхние резцы

562. Проявления позднего врожденного сифилиса возникают в возрасте:
1. после 2 лет
2. от 4 до 17 лет
3. от 17 до 20 лет
4. от 20 до 23 лет

563. Ранний врожденный сифилис проявляется в возрасте:
1. от рождения до 2 лет
2. от 2 до 3 лет
3. от 3 до 4 лет
4. от 4 до 5 лет

564. Сифилис грудного возраста проявляется в возрасте:
1. от 1 до 4 месяцев
2. от рождения до года
3. от рождения до 2 лет
4. до 28 дней

565. Профилактика врожденного сифилиса включает:
1. своевременное выявление и лечение больных сифилисом женщин
2. трехкратное исследование крови на RW во время беременности
3. профилактическое лечение
4. прерывание беременности
5. витаминотерапию

566. Возбудитель мягкого шанкра:
1. Treponema pallidum
2. Streptobacilus Ducrei
3. Chamidia trachomatis
4. Gardnerella vaginalis

567. Наиболее частые осложнения мягкого шанкра:
1. лимфангит
2. лимфаденит
3. фимоз
4. фагеденизм
5. перитонит

568. Для мягкого шанкра характерно:
1. очаги поражения образуются через 2-3 дня на месте внедрения стрептобацилл
2. имеется множество очагов
3. наклонность к аутоинокуляции
4. безболезненность

5. дно язвы неровно, покрыто гнойным отделяемым

569. 4-я венерическая болезнь вызывается:
1. вирусом
2. стрептококком
3. хламидией
4. спирохетой

570. Инкубационный период при венерическом лимфогранулематозе составляет:
1. 1 день
2. 1-2 недели
3. 3-4 недели
4. 5-6 недель
5. 7-8 недель

571. 4-ю венерическую болезнь следует дифференцировать с:
1. сифилисом
2. мягким шанкром
3. псориазом
4. экземой

572. Поздние осложнения 4-ой венерической болезни:
1. слоновость половых органов
2. полиневриты
3. периоститы
4. стриктуры уретры и прямой кишки

573. Для лечения 4-й венерической болезни применяют:
1. пенициллины
2. тетрациклины
3. кортикостероиды
4. цитостатики
5. фторхинолоны

574. Для гонококка характерные следующие признаки:
1. парность
2. грамм-отрицательная окраска
3. грамм-положительная окраска
4. шаровидная форма

575. Гонококки поражают:
1. слизистую уретры
2. слизистую глотки
3. слизистую ободочной кишки
4. слизистую прямой кишки

576. Наиболее доступным для поражения гонококками являются слизистые оболочки, выстланные:
1. многослойным плоским неороговевающим эпителием
2. переходным эпителием
3. цилиндрическим эпителием
4. многослойным плоским ороговевающим эпителием
5. кубическим эпителием

577. Метод окраски возбудителя гонореи:
1. бриллиантовым зелёным
2. по Грамму
3. метиленовым синим
4. по Шику
5. по Романовскому-Гимзе

578. Различают следующие клинические формы гонореи, кроме:

1. свежей острой
2. свежей подострой
3. свежей торпидной
4. латентной
5. хронической

579. Длительность инкубационного периода при острой гонорее чаще равна:
1. 1-2 дням
2. 3-4 дням
3. 5-7 дням
4. 8-10 дням
5. 10-14 дням

580. Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков с:
1. хламидиями
2. грибами
3. трихомонадами
4. уреаплазмой
5. гарднереллами

581. Какие осложнения могут возникать у мужчин при гонорее:
1. простатит
2. водянка яичка
3. орхоэпидидимит
4. баланопостит

582. Экстрагенитальные осложнения гонореи у мужчин:
1. перитонит
2. артрит (гонит)
3. эндокардит
4. фарингит

583. Какой материал берут для диагностики гонореи:
1. выделения из уретры
2. соскоб коньюнктивы
3. кровь из вены
4. пунктат лимфатического узла
5. соскоб слизистой прямой кишки

584. Какие среды используют для культурального исследования на гонорею:
1. Сабуро
2. агар-агар
3. асцит-агар
4. мясо-пептонный бульон

585. Методы провокации при диагностике гонореи:
1. микробиологическая
2. химическая
3. биологическая
4. механическая

586. Клинические формы хронического простатита:
1. катаральный
2. гнойный
3. фолликулярный
4. паренхиматозный

587. Свежий острый передний гонорейный уретрит характеризуется всеми перечисленными признаками, кроме:
1. обильных гнойных выделений
2. болезненности при мочеиспускании

3. гиперемии губок наружного отверстия уретры
4. наличия гнойных нитей в 1-й и 2-й порциях мочи
5. наличия гнойных нитей в 1-й порции мочи

588. Хронический тотальный гонорейный уретрит характеризуется следующими признаками, кроме:
1. застойно-гиперемированного цвета слизистой губок наружного отверстия уретры
2. капли «доброе утро»
3. болезненности в конце акта мочеиспускания
4. наличия незначительного количества гнойных нитей в 1-й и 2-й порциях мочи
5. наличия гнойных нитей в 1-й порции мочи

589. Комплексная терапия хронической гонорейной инфекции включает:
1. иммунотерапию
2. этиологическое лечение
3. симптоматическое лечение
4. местное лечение
5. все перечисленное

590. Методы местной терапии уретритов включают все перечисленное, кроме:
1. инстилляций
2. микроклизм
3. бужирований
4. тампонад

591. Для лечения гонореи применяют:
1. пенициллин
2. стрептомицин
3. сульфаниламиды
4. тетрациклин

592. Применение неспецифической терапии при гонорее:
1. пирогенал
2. кортикостероиды
3. биогенные стимуляторы
4. иммуномодуляторы

593. К ИППП не относят:
1. гонорею
2. хламидиоз
3. трихинеллез
4. трихомониаз
5. генитальный герпес

594. Назовите возбудителя трихомониаза:
1. Treponema pallidum
2. Trichomonas vaginalis
3. Haemophillus Ducrei
4. Chlamidia trachomatis
5. Gardnerella vaginalis

595. Укажите формы течения урогенитального трихомониаза:
1. острая
2. подострая
3. хроническая
4. торпидная
5. все верно

596. Назовите препарат выбора для лечения урогенитального трихомониаза:
1. доксициклин

2. азитромицин
3. метронидазол
4. кетоконазол

597. Трихомониаз у мужчин проявляется:
1. простатитом
2. эпидидимитом
3. аденомой предстательной железы
4. уретритом

598. Укажите возбудителя микоплазменной инфекции:
1. Mycoplasma hominis
2. Trichomonas vaginalis
3. Trichophyton rubrum
4. Microsporum canis

599. Какие лабораторные методы применяются для диагностики микоплазмоза:
1. бактериологический метод
2. ПЦР
3. серологический метод
4. исследование спинномозговой жидкости

600. Какие осложнения может вызвать микоплазменная инфекция у мужчин:
1. простатит
2. орхоэпидидимит
3. сепсис
4. параметрит
5. бесплодие

601. Возбудителем урогенитального хламидиоза является:
1. Treponema pallidum
2. Chlamydia trachomatis
3. Trichomonas vaginalis
4. Streptobacilus Haemophillus Ducrei
5. Gardnerella vaginalis

602. Цикл развития хламидий составляет:
1. 8-12 часов
2. 2-3 суток
3. 21 день
4. 4-6 месяцев

603. Заражение урогенитальным хламидиозом происходит:
1. воздушно-капельным путем
2. половым путем
3. гематрансфузионным путем
4. при прохождении ребенка через родовые пути матери

604. Какие формы хламидий являются инфекционными:
1. ретикулярные тельца
2. элементарные тельца
3. промежуточные (переходные) тельца
4. хламидийные включения

605. Какой материал берут для исследования методом ПЦР на хламидий:
1. выделения из уретры, шейки матки
2. соскоб из уретры, шейки матки
3. кровь
4. выделения из влагалища
5. моча

606. Укажите наиболее частые варианты течения урогенитального хламидиоза:
1. острое
2. подострое
3. малосимптомное
4. хроническое

5. все верно

607. При болезни Рейтера поражаются:
1. орган слуха
2. орган зрения
3. ЖКТ
4. мочеполовая система
5. опорно-двигательная система

608. Методы диагностики урогенитального хламидиоза:
1. ПЦР
2. МРП
3. РИФ
4. посев на культуру клеток
5. ИФА

609. Для лечения хламидий применяют:
1. пенициллин
2. сумамед
3. метронидазол
4. тетрациклин

610. Для лечения трихомониаза применяют:
1. тетрациклин
2. нистатин
3. трихопол
4. фазижин

611. Пути заражения ВИЧ-инфекцией:
1. парентеральный
2. трансплацентарный
3. половой
4. трансмиссивный

612. Симптомы, подозрительные на ВИЧ-инфекцию:
1. длительная лихорадка и диарея
2. генерализованная лимфаденопатия
3. саркома Капоши у молодых лиц
4. кандидозное поражение слизистых и кожи
5. все верно

613. Группы риска при ВИЧ-инфекции:
1. наркоманы
2. больные гемофилией
3. секс-работники
4. студенты

614. К стадии первичных проявлений ВИЧ-инфекции относятся:
1. прогрессирующая потеря массы тела
2. бессимптомная фаза
3. персистирующая генерализованная лимфаденопатия
4. длительная диарея
5. острая лихорадочная фаза

615. Какие инфекционные заболевания кожи характерны для ВИЧ-инфекции:
1. опоясывающий лишай
2. контагиозный моллюск
3. красный плоский лишай
4. широкие кондиломы

616. СПИДу могут сопутствовать:
1. оппортунистические инфекции внутренних органов
2. поражения нервной системы
3. эпидемическая саркома Капоши
4. волосатая лейкоплакия языка

5. все перечисленное

617. Выделяют формы саркомы Капоши, кроме:
1. доброкачественной
2. злокачественной
3. спорадической
4. эпидемической
5. иммуносупрессивной

618. Поражения кожи и слизистых наиболее характерные для ВИЧ-инфекции:
1. себорейный дерматит
2. вирусные заболевания
3. паразитарные заболевания
4. трофические заболевания кожи
5. грибковые заболевания

619. Препарат, наиболее эффективный для лечения грибковых инфекций у ВИЧ-инфицированных:
1. ацикловир
2. дифлюкан
3. макропен
4. кларитромицин
5. гризеофульвин

620. Препаратом базисной терапии при ВИЧ-инфекции является:
1. азидотимидин
2. макропен
3. орунгал
4. плаквенил

ОТВЕТЫ

1.	1	**51.**	4	**101.**	3	**151.**	1,2,3
2.	3	**52.**	1	**102.**	1,3	**152.**	1
3.	1	**53.**	3	**103.**	1	**153.**	3
4.	1	**54.**	1,2,4	**104.**	1,3,4	**154.**	3
5.	1	**55.**	4	**105.**	2,4	**155.**	1
6.	3	**56.**	4	**106.**	1,2	**156.**	1,3
7.	6	**57.**	2,4	**107.**	2,3	**157.**	1,2,3,4
8.	1	**58.**	1,2,3	**108.**	1,3	**158.**	1,2,4
9.	1,2,4	**59.**	1,2,3	**109.**	1	**159.**	3
10.	1	**60.**	1	**110.**	1,3	**160.**	1
11.	1,3	**61.**	4	**111.**	1,3,4	**161.**	1
12.	1,2	**62.**	1	**112.**	1,2,3	**162.**	1,2,3,4,5,6,7,8
13.	1,2,3,4	**63.**	1,2,3	**113.**	1,3	**163.**	2
14.	2,3	**64.**	2	**114.**	1	**164.**	1,2,3,4
15.	1,4	**65.**	2	**115.**	1,2,3,4	**165.**	4
16.	2,3	**66.**	2,3	**116.**	1	**166.**	3
17.	2,4	**67.**	1,2	**117.**	2	**167.**	1,2,3
18.	3	**68.**	2	**118.**	3	**168.**	1,2,4
19.	1	**69.**	1,2,4	**119.**	1,3	**169.**	1,2
20.	2	**70.**	2,3,4	**120.**	1,2,3	**170.**	3
21.	1	**71.**	1,3,4	**121.**	1	**171.**	1
22.	1	**72.**	2	**122.**	1	**172.**	2
23.	1	**73.**	2	**123.**	2,3	**173.**	1,2,3,4,5
24.	1	**74.**	2	**124.**	1,2	**174.**	1,3,5
25.	1,2,3,4	**75.**	2,3	**125.**	1,2,3	**175.**	1,2,3
26.	1,2,3	**76.**	2	**126.**	2,3	**176.**	1,2
27.	1,2,3,4	**77.**	2,4	**127.**	1,4	**177.**	2
28.	1,2	**78.**	2,3	**128.**	2	**178.**	2
29.	1	**79.**	1,2,3	**129.**	1,2,3	**179.**	2
30.	1,2	**80.**	1,2	**130.**	2,3	**180.**	1
31.	1,2,3	**81.**	1,2,3	**131.**	3	**181.**	1
32.	1,2	**82.**	1	**132.**	3	**182.**	1
33.	3,4	**83.**	1,2	**133.**	1,2,3	**183.**	3
34.	1,2,3,4	**84.**	1,2,3	**134.**	1,2,3	**184.**	1
35.	1,2,3	**85.**	2	**135.**	1,4	**185.**	1,3,4
36.	2,3,4	**86.**	2,3	**136.**	1,2,3	**186.**	2
37.	1,2,3,4	**87.**	1,2,3	**137.**	1,2,3,4	**187.**	2
38.	1,2,4	**88.**	2	**138.**	1,2,4	**188.**	2,4
39.	1,2	**89.**	1,2,3	**139.**	1,3,4	**189.**	1,2,3,4,5
40.	1,2,3,4	**90.**	1	**140.**	1	**190.**	1,3
41.	1,3,4	**91.**	1,2	**141.**	1,3	**191.**	1,2,3,4
42.	1,3,4	**92.**	1,2,3	**142.**	1,2,3	**192.**	2
43.	1,3,4	**93.**	1,2	**143.**	1,2,3	**193.**	2,3
44.	1,3	**94.**	1,2,3	**144.**	1,2,3,4	**194.**	1,2,3,4
45.	1,2,4	**95.**	1,2,3	**145.**	1,3,4	**195.**	1,2,4
46.	4	**96.**	3	**146.**	1,2,3,4	**196.**	4
47.	2	**97.**	2	**147.**	1,2,3	**197.**	1,3,4
48.	2,3	**98.**	1,2	**148.**	1	**198.**	1,2,4
49.	1	**99.**	1,2,3	**149.**	1	**199.**	2
50.	1,2	**100.**	3	**150.**	2,3	**200.**	1,2

201	1,2,3,4	**251.**	1	**301.**	1,2,4	**351.**	3
202.	1,2,3,4	**252.**	1,3,4	**302.**	1,2	**352.**	1,2,3,4
203.	1,3,4	**253.**	4	**303.**	3	**353.**	1
204.	1,2,3	**254.**	1	**304.**	1,2	**354.**	3
205.	2,3	**255.**	2,3	**305.**	1	**355.**	1
206.	1,3	**256.**	1	**306.**	1	**356.**	1
207.	4	**257.**	2	**307.**	4	**357.**	2,4
208.	2,3	**258.**	1	**308.**	1,2,3	**358.**	1,3
209.	1,2	**259.**	2,4	**309.**	1,2,3	**359.**	1,3
210.	1	**260.**	1	**310.**	2,3,4	**360.**	2
211.	3	**261.**	2	**311.**	1,2	**361.**	1,2,3
212.	2	**262.**	2	**312.**	1,2	**362.**	1
213.	1,2,4	**263.**	1	**313.**	1,2,3,4	**363.**	1,3
214.	2,3,4	**264.**	1,2,4	**314.**	1,2,3,4	**364.**	2
215.	1	**265.**	2	**315.**	2,4	**365.**	1,2
216.	1,3,4	**266.**	1,2,3,4	**316.**	1,3,4	**366.**	2,3,4
217.	3	**267.**	1	**317.**	1,2,3,4,5	**367.**	1,2
218.	1	**268.**	4	**318.**	1,4	**368.**	4
219.	2	**269.**	1,3,4	**319.**	1	**369.**	3
220.	2,3,4	**270.**	3,4	**320.**	1	**370.**	3
221.	1,2,3	**271.**	3	**321.**	1	**371.**	3
222.	2,3,4	**272.**	2,4	**322.**	2,4	**372.**	3
223.	1,2,3	**273.**	2	**323.**	1,3,4	**373.**	3
224.	1,2,3,4	**274.**	2	**324.**	2,3	**374.**	3
225.	1,2,3,4	**275.**	1	**325.**	3	**375.**	1
226.	4	**276.**	1,2	**326.**	1	**376.**	2
227.	2,3	**277.**	3	**327.**	2	**377.**	1,2
228.	1,2,3,4	**278.**	1,2	**328.**	1,4	**378.**	2
229.	1,2,3	**279.**	1,3	**329.**	1,3	**379.**	2,4
230.	1,2,3,4	**280.**	1,2,4	**330.**	1,2	**380.**	1,2
231.	1,2,3,4	**281.**	1	**331.**	1,2,3,4	**381.**	2,3,4
232.	1,2,3	**282.**	1,2,3	**332.**	2	**382.**	3
233.	2,4	**283.**	1,3,4	**333.**	1,3	**383.**	1
234.	1,2,3,4	**284.**	1,2,3	**334.**	4	**384.**	4
235.	4	**285.**	2,3,4	**335.**	1,2,3	**385.**	2
236.	1,2,3,4	**286.**	1,3	**336.**	1,3,4	**386.**	1,3,4
237.	1,3,4	**287.**	1,2,3	**337.**	1,2,4	**387.**	2,4
238.	2	**288.**	1,2,3,4,5	**338.**	1	**388.**	2
239.	1	**289.**	1,2,3	**339.**	2,3	**389.**	1,2,3,4
240.	1,2,3,4	**290.**	2,4	**340.**	2,3	**390.**	1,2,3
241.	1	**291.**	1,2,3,4	**341.**	2	**391.**	3
242.	1,2	**292.**	3,4	**342.**	1,2,3,4	**392.**	3
243.	1,2,3,4	**293.**	2,4	**343.**	2,3	**393.**	1,2
244.	1,2,3	**294.**	2,3	**344.**	2,3,4	**394.**	1,2
245.	1,2,3,4	**295.**	3	**345.**	1,2	**395.**	1,2
246.	1,2	**296.**	1	**346.**	1,2	**396.**	2
247.	1,2,3	**297.**	1,3,4	**347.**	2	**397.**	1
248.	2,3	**298.**	1,3	**348.**	1	**398.**	1
249.	1,2,3	**299.**	1,2,3	**349.**	1,2,4	**399.**	3
250.	4	**300**	2	**350.**	2,3,4	**400.**	1,2

401.	1	**451.**	2,3	**501.**	1,2,3,5	**551.**	1,3
402.	1,2	**452.**	1,5	**502.**	1,3,4,5	**552.**	1,2,4
403.	1,2	**453.**	1,2,3	**503.**	3	**553.**	1,3,5
404.	1,2	**454.**	1,3,4,5	**504.**	2,4	**554.**	1,3,5
405.	1,2,3	**455.**	1,4,5	**505.**	1	**555.**	1,2,3,4
406.	1	**456.**	1,3	**506.**	1	**556.**	1,2,3,4
407.	3	**457.**	2	**507.**	3	**557.**	1,2,3,5
408.	1	**458.**	1,2,4	**508.**	1,3,4,5	**558.**	2,3
409.	1,3	**459.**	1,3,5	**509.**	1,2,3,5	**559.**	2
410.	1,2,3	**460.**	2,3,5	**510.**	1,5	**560.**	2,4
411.	1,2	**461.**	2	**511.**	1	**561.**	1,2,3,4
412.	1,2,3	**462.**	2,3	**512.**	2	**562.**	1
413.	1	**463.**	2,3,4	**513.**	1,3,4	**563.**	1
414.	1,2	**464.**	1,2,3	**514.**	1	**564.**	2
415.	2	**465.**	1	**515.**	3	**565.**	1,2,3
416.	2,3,4	**466.**	3	**516.**	2	**566.**	2
417.	2	**467.**	1,2,4,5	**517.**	1,3	**567.**	1,2,3
418.	1,2,4	**468.**	2	**518.**	1	**568.**	1,2,3,5
419.	1,4	**469.**	1,4	**519.**	3	**569.**	3
420.	1,2	**470.**	1,3,5	**520.**	2,4	**570.**	3
421.	3	**471.**	1,4	**521.**	1	**571.**	1,2
422.	1,2	**472.**	2	**522.**	5	**572.**	1,4
423.	1,2,4	**473.**	2,3	**523.**	1,2,3	**573.**	2,5
424.	1,2,3	**474.**	1,2,3	**524.**	1,2,4	**574.**	1,2
425.	1,2,4	**475.**	1,2,3	**525.**	1,2,3,4	**575.**	1,2,4
426.	1,2,3,4	**476.**	1,3	**526.**	3,5	**576.**	3
427.	1,2,3,4	**477.**	1,4	**527.**	4	**577.**	2,3
428.	1,2,4	**478.**	2	**528.**	1,3,5	**578.**	4
429.	1,2,3,4	**479.**	3	**529.**	1,3,5	**579.**	2
430.	3	**480.**	2,3,4	**530.**	2,4	**580.**	3
431.	2,3,4	**481.**	2,4	**531.**	1,3,5	**581.**	1,3,4
432.	1,3	**482.**	1,2,4,5	**532.**	2	**582.**	2,3,4
433.	1,2,4	**483.**	1	**533.**	4	**583.**	1,2,5
434.	3	**484.**	2	**534.**	4	**584.**	3
435.	2,3	**485.**	2	**535.**	1,2,3,4	**585.**	2,3,4
436.	2,4	**486.**	2	**536.**	5	**586.**	1,3,4
437.	1,3,4	**487.**	2	**537.**	5	**587.**	4
438.	1,3,4	**488.**	1	**538.**	1,2,3,4,5	**588.**	5
439.	1,3,4	**489.**	5	**539.**	2,5	**589.**	5
440.	1,2,3	**490.**	1,2	**540.**	2	**590.**	2
441	1,2,3	**491.**	1,3,4	**541.**	5	**591.**	1,3,4
442.	1,2	**492.**	1,3	**542.**	1,2,3	**592.**	1,3,4
443.	1,2,3	**493.**	3	**543.**	1,2,3	**593.**	3
444.	1	**494.**	1,3,5	**544.**	1,3	**594.**	2
445.	3	**495.**	1,5	**545.**	3	**595.**	5
446.	1,2	**496.**	2	**546.**	5	**596.**	3
447.	1,5	**497.**	3	**547.**	1,2,3	**597.**	1,2,4
448.	1,2,3,5	**498.**	2,3,4,5	**548.**	1,2,3	**598.**	1
449.	4	**499.**	2,3,5	**549.**	4	**599.**	1,2,
450.	1	**500**	2,4,5	**550.**	2,3,5	**600.**	1,2,5

601.	2	**606.**	2,3,4	**611.**	1,2,3	**616.**	5
602.	3	**607.**	2,4,5	**612.**	5	**617.**	1
603.	2,4	**608.**	1,3,4,5	**613.**	1,2,3	**618.**	1,2,5
604.	2	**609.**	2,4	**614.**	2,3,5	**619.**	2
605.	2	**610.**	3,4	**615.**	1,2	**620.**	1